Grupos de Estudio Lalangue

PSIQUE, CUERPO Y TRAMA VINCULAR

Abordaje trifocal del trauma: el cuerpo en terapia desde el psicoanálisis y las neurociencias afectivas

COLECCIÓN Grupos de Estudio Lalangue





Facultad Internacional de Psicología y Psicoanálisis Lalangue en colaboración con la Dra. Verónica Molina Gerstner y Lorena Salthu

Grupos de Estudio Lalangue

PSIQUE, CUERPO Y TRAMA VINCULAR

Abordaje trifocal del trauma: **el cuerpo en terapia** desde el psicoanálisis y las neurociencias afectivas.

Producción Editorial PLUMA LALANGUE 2026

COLECCIÓN Grupos de Estudio Lalangue

Prólogo
La inteligencia evolutiva del síntoma

La clínica psicoanalítica del siglo XXI nos enfrenta a un desafío insoslayable: el abordaje del sufrimiento humano en toda su complejidad estructural, vincular y somática. Fiel a su posicionamiento ético y epistemológico, la Facultad LALANGUE sostiene la rigurosidad del psicoanálisis inaugurado por Freud y continuado por autores como Lacan, Klein, Winnicott y Bion, no como un dogma cerrado, sino como un marco conceptual vivo, capaz de dialogar con los avances científicos contemporáneos para responder a los padecimientos de nuestra época.

En este contexto surge el grupo de estudio El cuerpo en terapia, un espacio de investigación y transmisión concebido para interrogar aquellos síntomas que se resisten a la dialectización exclusiva de la palabra, bajo la dirección de la Dra. VMG. Con frecuencia, en la intimidad del consultorio, nos encontramos frente a dolores mudos, repeticiones inquebrantables y angustias sin nombre que no logran encontrar escenario en el teatro de la mente y terminan por escenificarse en el cuerpo. Ante este límite, la Dra. VMG nos propone una ampliación de la escucha clínica a través de la Teoría Trifocal del Trauma ®, integrando la dimensión individual, sistémica y colectiva, articulando la metapsicología con la Neurobiología del Apego y la Teoría Polivagal.

En este ebook la Dra. VMG propone analizar el trauma no como una falla mecánica del aparato psíquico, sino como una manifestación de la Inteligencia Evolutiva. Desde esta perspectiva, el síntoma y la respuesta defensiva del organismo son intentos desesperados —y a menudo biológicamente brillantes— de preservar la vida frente a lo inasimilable. Sin embargo, cuando esa respuesta se cronifica, el trauma comienza a dictar la relación del sujeto con su propio cuerpo, con sus vínculos y con el mundo.

A lo largo de estas páginas, se despliega el Enfoque Trifocal®: un modelo que busca abordar la complejidad del sufrimiento humano desde tres dimensiones inseparables: la individual, la sistémica y la social/colectiva. No es posible pensar el dolor de un sujeto sin considerar la trama de lealtades invisibles de su sistema familiar o el impacto de los traumas colectivos que moldean la sociedad en la que está inserto.

El rigor científico de esta obra, se apoya en los hallazgos contemporáneos de la Teoría Polivagal y la Epigenética Transgeneracional. Se examina cómo el estrés psicosocial y las experiencias abrumadoras de nuestros ancestros pueden dejar huellas en la expresión de nuestros genes, pero también, y fundamentalmente, cómo la plasticidad humana permite que la psicoterapia actúe como un agente de cambio biológico, capaz de revertir impresiones, habilitando nuevas formas de existencia.

El abordaje Trifocal® del Trauma, propuesto por la Dra. VMG, integra tres dimensiones de lectura clínica —individual, sistémico y colectivo— como también a nivel del cuerpo, la emoción y la cognición, articulando aportes del Psicoanálisis, la Neurobiología del Estrés, la Teoría del Apego, Experiencia Somática, la Teoría Polivagal, la Teoría del Trauma y la Sociología Clínica, entre

otras. Sanar, en este contexto, no se define como un retorno idílico al estadio previo al trauma. Sanar es un proceso de evolución. Como sostiene la Dra. VMG, el objetivo de la intervención clínica no es recuperar a quienes éramos, sino integrar la experiencia para *evolucionar a una mayor sabiduría*. Este libro invita a profesionales de la salud, la educación y el campo social a sumergirse en una lectura que no busca certezas cerradas, sino aperturas cognitivas para acompañar la complejidad del alma y el cuerpo en terapia.

En un tiempo donde el saber tiende a fragmentarse y a volverse consumo rápido, la apuesta de la Facultad LALANGUE insiste en sostener otra temporalidad: la de la transmisión, la del trabajo sobre los textos y la de una clínica que no renuncia a la complejidad.

Este ebook forma parte de ese movimiento. No como exposición de verdades acabadas, sino como efecto de una práctica colectiva de lectura, discusión e interrogación. En este sentido, cada grupo de estudio constituye un espacio donde el conocimiento no se acumula, sino que circula, se tensiona, se pone en riesgo. Porque si algo nos ha enseñado la historia del psicoanálisis es que su vitalidad depende menos de la fidelidad a un dogma que de la capacidad de releer, de desplazar, incluso de disentir.

Freud mismo advertía sobre el peligro de transformar la teoría en catecismo, invitando a revisar y rehacer los propios caminos cuando estos dejan de producir efectos . Retomar esa ética implica hoy sostener un psicoanálisis en diálogo: con las ciencias contemporáneas, con la filosofía, con las transformaciones sociales y con las nuevas formas del sufrimiento. Pero también —y no menos importante— en diálogo con las diferentes corrientes que habitan su interior, sin reducirlas a posiciones enemigas.

Desde esta perspectiva, la Facultad se posiciona como un espacio internacional de formación en psicología y psicoanálisis que promueve la democratización del saber: un saber que no pertenece a unos pocos, ni se transmite por autoridad, sino que se construye en la experiencia, en la pregunta y en el encuentro con otros. ¿Cómo pensar hoy la clínica sin caer en reduccionismos biologicistas o en idealismos desconectados del cuerpo y de la época? ¿Qué lugar otorgar a los avances de la neurociencia sin perder la especificidad de lo inconsciente? ¿Es posible sostener la rigurosidad sin rigidizar el pensamiento?

Este volumen se inscribe en esas preguntas. No pretende clausurarlas, sino más bien abrirlas. En él, el síntoma es abordado no como un error a corregir, sino como una formación que, incluso en su dimensión más sufriente, porta una lógica, una historia y, quizás, una forma de respuesta singular frente a lo traumático. Tal como el psicoanálisis nos ha enseñado, allí donde algo insiste, se juega una verdad que no puede ser apresada de manera directa, pero que orienta la escucha clínica .

Como decana, mi posición no es la de quien dicta un camino único, sino la de quien apuesta a la apertura de múltiples trayectorias posibles. Sostener un pensamiento crítico implica, ante todo, tolerar la diferencia, habitar la controversia y hacer de ella un motor de producción, no un obstáculo. Quizás allí resida hoy la verdadera innovación: no en agregar nuevos conceptos, sino en mantener viva la pregunta.

Lorena Salthu
Decana FIPP Lalangue

Índice

Prólogo **2**
La inteligencia evolutiva del síntoma **2**
CAPÍTULO I: LA NATURALEZA DEL TRAUMA Y EL PROCESO DE ELABORACIÓN **7**
1. El desafío de la praxis: Acompañar el sufrimiento en el siglo XXI 7
2. La genealogía del concepto: De la herida a la economía energética 7
3. La metáfora del contenedor: El psiquismo como "olla de arroz" 8
4. El teatro del cuerpo: cuando el dolor no encuentra escenario en la mente 9
5. La atención flotante ampliada: Escuchar el lenguaje del soma 10
6. El trauma como inteligencia evolutiva y punto de fijación 11
Conclusión del Capítulo I 11
CAPÍTULO II: EL ENFOQUE TRIFOCAL DEL TRAUMA **12**
1. La necesidad de un cambio de paradigma 12
2. La arquitectura del Modelo Trifocal: Círculos concéntricos de afectación 12
3. Foco Individual: Cristalización de la biografía temprana 13
Caso Clínico: La inmovilidad como memoria somática 13
4. Foco Sistémico: Las lealtades invisibles y el libro contable familiar 14
Caso Clínico: El pedido de ir a la cárcel 14
5. Foco Colectivo: El eco de la historia en el cuerpo 14
Caso Clínico: La culpa del sobreviviente y Malvinas 15
6. Epigenética: El sustrato biológico de la transmisión 15
7. El Genograma como herramienta diagnóstica y analítica 16
Conclusión del Capítulo II 16
CAPÍTULO III: LA FISIOLOGÍA DE LA DEFENSA Y LA TEORÍA POLIVAGAL **17**
1. El sustrato biológico en el campo del Otro 17
2. El Sistema Nervioso Autónomo: Vigilia, descanso y defensa 17
3. La Teoría Polivagal: La necesidad filogenética del otro 18
a. La vía Vago Ventral (Conexión Social) 18
b. El Sistema Simpático (Movilización) 19
c. La vía Vago Dorsal (Inmovilización) 19
4. Neurocepción: El escáner automático de seguridad 19
5. La gramática de la naturaleza: El Oso y la Gacela 19
El Oso Pequeño y el Puma (Hiperactivación) 19
La Gacela y la Hiena (Hipoactivación) 19
6. Peter Levine y la respuesta inhibida 20
7. El proceso clínico: Del congelamiento a la descarga 20
8. La corregulación como herramienta ética 21
Conclusión del Capítulo III 21
CAPÍTULO IV: LA TRAMA TRANSGENERACIONAL Y EL TRAUMA SISTÉMICO **22**
1. El ser humano como eslabón generacional 22
2. Lo indecible, lo innombrable y lo impensable 22
3. La Cripta y el Fantasma: Los secretos encriptados 23
4. Justicia transgeneracional y lealtades invisibles 24
Caso clínico: La lealtad al linaje biológico 24

5. El cuerpo como registro de lo no tramitado..... 25
La perspectiva de Dolto..... 25
6. La brújula del genograma..... 26
7. Vocación y reparación transgeneracional..... 26
Conclusión del Capítulo IV..... 26
CAPÍTULO V: EPIGENÉTICA TRANSGENERACIONAL Y PLASTICIDAD..... 28
1. El ADN no es el destino: Una nueva frontera clínica..... 28
2. Mecanismos moleculares: Metilación y regulación génica..... 28
3. La herencia somática: Alcances y límites de la evidencia..... 29
Sobrevivientes del Holocausto..... 29
El estudio del 11 de septiembre..... 29
La Hambruna de Holanda..... 29
Ex prisioneros de guerra..... 29
4. La clínica del síntoma y el mapa epigenético..... 30
Articulación con Bion y Winnicott..... 30
5. Plasticidad y cambio..... 30
Conclusión del Capítulo V..... 31
CAPÍTULO VI: DERIVACIONES PRÁCTICAS Y CLÍNICA DE LA SABIDURÍA..... 32
1. La praxis clínica en el siglo XXI: El analista como detector de señales..... 32
¿Cómo integramos las "lupas" del enfoque trifocal en la sesión?..... 32
2. El cuerpo en la transferencia: La corregulación como motor de la cura..... 33
¿Por qué es necesaria la presencia vago-ventral del analista?..... 33
3. El proceso de "desanudar": Del congelamiento a la palabra..... 33
¿Cuál es la ruta clínica de la descarga?..... 33
4. El síntoma como inteligencia evolutiva..... 34
¿Cómo transformamos la herida en sabiduría?..... 34
5. Una nueva definición de Salud: La perspectiva vincular..... 34
¿Qué dimensiones componen la salud en el siglo XXI?..... 34
Conclusión del Capítulo VI..... 35
CONCLUSIONES: HACIA UNA INTEGRACIÓN CLÍNICA EVOLUTIVA..... 35
El Psiquismo como Tejido Vincular y Biológico..... 35
La Dimensión Económica del Trauma..... 36
El Epigenoma: El Archivo de lo innombrable..... 36
La Ética de la Corregulación en el Dispositivo Analítico..... 37
La Plasticidad como Horizonte de Esperanza..... 37
Reflexión Final..... 38
BIBLIOGRAFÍA..... 39
GLOSARIO CONCEPTUAL..... 41
Capacidad de rêverie:..... 41
Corregulación:..... 41
Cripta y Fantasma (transgeneracional):..... 41
Elementos beta:..... 41
Epigenética:..... 41
Hiperactivación:..... 41
Hipoactivación:..... 41
Lealtades invisibles:..... 42

Metilación del ADN:.....42
Neurocepción:.....42
Resiliencia:.....42
Teoría polivagal:.....42
Transmisión transgeneracional:.....42
Trauma trifocal:.....42
ANEXOS.....43
I. Infografía: Lectura Clínica del Mapa Epigenético y el Trauma Trifocal.....43
II. Artículo: Familia, Trauma y Salud, por Verónica Molina Gerstner.....45
La dimensión individual del trauma.....49
La transmisión de la vida psíquica.....50
De la familia a la cultura.....53

CAPÍTULO I: LA NATURALEZA DEL TRAUMA Y EL PROCESO DE ELABORACIÓN

Hacia una redefinición de la situación abrumadora en la clínica contemporánea

Preguntas nodales del capítulo:

- *¿De qué manera el concepto de trauma ha evolucionado desde la economía libidinal freudiana hasta las neurociencias afectivas?*
- *¿Cómo influye la relación entre el "quántum de excitación" y la capacidad del "contenedor psíquico" en la formación del síntoma?*
- *¿Qué papel juega el cuerpo como escenario de lo inasimilable cuando la palabra y la representación simbólica fracasan?*

1. El desafío de la praxis: Acompañar el sufrimiento en el siglo XXI

El trabajo cotidiano en el consultorio nos enfrenta de manera ineludible a lo que constituye, quizás, nuestro mayor desafío ético y profesional: el acto de acompañar a sujetos sufrientes a través de la densa trama de sus historias de vida.

En el ejercicio de esta praxis, nos encontramos con momentos de genuino alivio y procesos de cura; sin embargo, con una frecuencia que nos obliga a la reflexión, nos topamos con obstáculos que parecen infranqueables: repeticiones inquebrantables, migraciones de un síntoma a otro y dolores crónicos que simplemente no ceden ante el abordaje terapéutico tradicional orientado únicamente a la palabra.

Esta realidad clínica persistente nos empuja a la investigación y nos obliga a preguntarnos: ¿de qué otra manera podemos mirar y acompañar a esa persona que transita una dolencia?

En el contexto global actual, especialmente tras la irrupción de la pandemia, el término trauma ha dejado de ser un concepto técnico exclusivo de los manuales de psiquiatría para integrarse en el lenguaje cotidiano. Existe hoy una claridad social mucho mayor sobre cómo un evento puede ser profunda y colectivamente estresante.

No obstante, para que este concepto no pierda su espesor metapsicológico y su utilidad en la psicoterapia de orientación psicoanalítica, es imperativo que revisemos su genealogía y su evolución dentro de nuestra disciplina.

2. La genealogía del concepto: De la herida a la economía energética

Quien sentó las bases para hablar de trauma con una lucidez teórica fundacional fue Sigmund Freud. Su encuentro con el fenómeno traumático no fue teórico, sino clínico y social. Durante la Primera Guerra Mundial, mientras él desarrollaba su teoría del psiquismo desde una perspectiva

centrada en la sexualidad y el conflicto pulsional, irrumpió la catástrofe bélica.



Freud comenzó a observar un fenómeno paradójico en los soldados que regresaban del frente: hombres que ya se encontraban en lugares seguros, con sus necesidades básicas de abrigo y alimento cubiertas, permanecían, a pesar de ello, atrapados en el contacto con las imágenes y las experiencias aterradoras vividas en las trincheras.

Esta observación clínica lo obligó a repensar el modelo económico del psiquismo. En sus textos, finalmente, Freud enuncia una definición clásica que hoy, a la luz de las neurociencias, cobra una vigencia renovada: el trauma es "una experiencia vivida que aporta, en poco tiempo, un aumento tan grande de excitación a la vida psíquica, que fracasa su liquidación o su elaboración por los medios normales y habituales". Esto da lugar a trastornos duraderos en el funcionamiento energético del sujeto. No se trata simplemente de un "mal recuerdo", sino de un aflujo de excitaciones que resulta excesivo en relación a la tolerancia del aparato psíquico.

Posteriormente, en su obra cumbre *Más allá del principio del placer*, Freud amplía esta visión al plantear que un aflujo excesivo de excitación anula inmediatamente el principio de placer que rige la vida mental.

Ante este desborde, el aparato psíquico se ve obligado a realizar una tarea mucho más urgente y biológica: intentar "ligar" esas excitaciones erráticas para posibilitar una descarga futura. De este esfuerzo desesperado nacen los sueños traumáticos, donde el sujeto revive la experiencia una y otra vez en un intento ciego por ganar control sobre lo que originalmente lo inmovilizó. A este fenómeno Freud lo denominó compulsión a la repetición, evidenciando que el traumatismo es una amenaza radical a la integridad misma del sujeto.

En este sentido, el trauma, en su acepción original de "herida", sobreviene como un recurso de supervivencia. Es una inteligencia escisionaria que deja por fuera de la conciencia el caudal emocional intolerable para permitir que el individuo, aunque fragmentado, siga adelante.

3. La metáfora del contenedor: El psiquismo como "olla de arroz"

Si bien las definiciones clásicas de Freud nos permiten comprender el impacto de situaciones extremas —guerras, torturas o abusos—, la clínica actual nos arroja interrogantes más sutiles.

¿Qué sucede cuando aparecen sintomatologías propias del estrés postraumático ante eventos que no poseen esa magnitud de catástrofe externa?

Para abordar esta paradoja, la Dra. VMG introduce la metáfora de la **"olla desbordada de arroz"**.

Podemos concebir el psiquismo de un sujeto como un contenedor, semejante a una olla. En la evaluación del trauma, no

solo debemos mirar la carga traumática o el estresor en sí mismo (la cantidad de arroz), sino que es vital observar el estado del contenedor. Este receptáculo no es estático; es flexible, variable y profundamente dinámico a lo largo de la vida.



Consideremos el caso clínico de una cirugía programada expuesto en los encuentros. Imaginemos a una paciente, una mujer de edad avanzada, que debe someterse a la extirpación del útero debido a fibromas.

La intervención ocurre en condiciones de total seguridad médica y bajo anestesia; su vida no corre peligro inminente ni está en juego su deseo de maternidad. Sin embargo, luego de la cirugía, esta mujer desarrolla síntomas característicos del trauma: hipertensión arterial persistente, ansiedad, insomnio u otras alteraciones somáticas. ¿Por qué un evento catalogado como "normal" deviene traumático?

La respuesta reside en la capacidad de metabolización del contenedor psíquico en ese momento determinado. Al ampliar la mirada sobre el contexto de esta mujer, descubrimos que hace poco tiempo enviudó, que vive en un país atravesado por crisis económicas severas y que mantiene conflictos constantes con sus hijos.

En ese punto específico de su historia, su contenedor psíquico se encuentra drásticamente reducido; no hay espacio interno disponible. Por lo tanto, un estresor que en otro momento vital hubiera sido asimilable, la encuentra sobrepasada y resulta ser demasiado abrumador.

El trauma, en consecuencia, no reside únicamente en el evento externo, sino en la ecuación singular entre el volumen de la excitación y la capacidad de metabolización de la estructura psíquica en un tiempo y contexto determinados.

4. El teatro del cuerpo: cuando el dolor no encuentra escenario en la mente

Cuando la capacidad de metabolización psíquica fracasa y el contenedor se desborda, la representación simbólica es incapaz de ligar la excitación traumática. Ante este vacío de palabras, el sufrimiento exige inexorablemente una vía de descarga alternativa. Es aquí donde el psicoanálisis estructural y las neurociencias encuentran un territorio común de inmenso valor clínico.

La destacada psicoanalista Joyce McDougall ilumina este fenómeno de manera brillante al postular que "el dolor que no tiene espacio en la conciencia, encuentra escenario en el cuerpo".



Según sus desarrollos sobre la clínica psicosomática, cuando nos enfrentamos a amenazas psicológicas que resultan intolerables para nuestro aparato de representación, el cuerpo puede reaccionar como si se tratara de una amenaza puramente fisiológica. Se produce entonces un clivaje agudo entre la psique y el soma.

En el seminario se discutió cómo la estructura psicosomática no es meramente una falla orgánica, sino una "vía anexa" del psiquismo, absolutamente inconsciente, que se forja usualmente en la primera infancia. Esta vía se crea cuando el entorno temprano carece de la disponibilidad suficiente para ofrecer un espacio de simbolización adecuado. Si no hay un "otro" —un cuidador— capaz de generar un lazo con la palabra, que pueda traducir, nombrar y dar sentido a lo que el bebé está sintiendo, el sujeto se enfrenta a una soledad desbordante.

Ante la ausencia de una mirada que provea "corregulación", lo que no logra alojarse en el "teatro de la mente" es derivado de manera directa al escenario somático. El psiquismo entonces, busca equilibrio en el cuerpo.

Esta comprensión resulta vital en nuestra praxis, ya que las personalidades psicosomáticas se caracterizan por no tolerar grandes movilizaciones afectivas.

Ante montos de angustia elevados, el conflicto va directo al cuerpo. Por lo tanto, el trabajo terapéutico con estas presentaciones clínicas debe ser sumamente delicado.

5. La atención flotante ampliada: Escuchar el lenguaje del soma

La invitación central de este enfoque integrativo es ampliar nuestra atención flotante para empezar a escuchar el lenguaje somático como un portador de sentido. A través de las sensaciones corporales —que escapan a las defensas puramente cognitivas— el paciente nos está relatando la memoria de lo no dicho.

En el trabajo analítico propuesto por la Dra. VMG, se vuelve notable trazar ese camino inverso: transitar desde el cuerpo y sus sensaciones mudas, hacia la emoción, y finalmente, hacia el restablecimiento de la palabra y la representación.

Como señala la Decana Lorena durante el encuentro, todo lo articulado empieza a tener registros corporales: desde una contractura o un malestar estomacal hasta una jaqueca. Todo lo que queda por fuera de la cadena significante tiene un registro allí, pues el inconsciente y el cuerpo están "muy pegados" cuando la palabra no media.



6. El trauma como inteligencia evolutiva y punto de fijación

Desde el psicoanálisis, no medimos el trauma por la intensidad objetiva del evento, sino por su efecto de ruptura en la historia del sujeto.

Decimos que hubo un trauma porque para esa persona hubo un "antes y un después", generando un punto de fijación donde la psique queda atrapada en la repetición. Freud advirtió con claridad cómo lo no elaborado vuelve, repite y se reescenifica constantemente.

La integración de las teorías somáticas es profundamente complementaria a esta visión.

Nos enseña que los síntomas corporales no son disfunciones biológicas aleatorias, sino intentos desesperados del organismo por traer esa escena traumática fundamental al presente, con el objetivo ciego de resolver algo que quedó pendiente allí.



Las defensas tomaron decisiones drásticas en el pasado para que el sujeto pudiera seguir adelante; nuestro trabajo consiste en irlas deshilando y encontrándoles una articulación simbólica.

Conclusión del Capítulo I

El recorrido realizado en este capítulo nos permite resituar el trauma en el centro de la complejidad clínica actual. Hemos transitado desde la noción freudiana de la "herida" psíquica y el desborde económico del aparato mental, hasta la comprensión de que el cuerpo se convierte en el teatro de operaciones cuando la palabra fracasa.

La metáfora de la "olla de arroz" nos deja una advertencia fundamental: el terapeuta no debe evaluar el impacto de un evento de forma aislada, sino siempre en relación con la flexibilidad del "contenedor" del paciente. Entendemos ahora que el síntoma somático es el mensajero de una historia interrumpida que busca su conclusión.

Con este cimiento teórico, estamos preparados para explorar en el siguiente capítulo, cómo esta complejidad se organiza integrando las dimensiones individual, sistémica y colectiva a través del **Enfoque Trifocal**.

CAPÍTULO II: EL ENFOQUE TRIFOCAL DEL TRAUMA

Hacia una clínica de la complejidad: Mente, Emoción y Cuerpo.

Preguntas nodales del capítulo:

- *¿Por qué la clínica del siglo XXI exige superar la visión individualista para adoptar un abordaje trifocal?*
- *¿De qué manera se interrelacionan los registros somático, emocional y cognitivo en los diferentes niveles de afectación?*
- *¿Cómo se inscribe la historia colectiva y sistémica en la biología del sujeto a través de la epigenética?*

1. La necesidad de un cambio de paradigma

La práctica psicoanalítica contemporánea nos enseña que el sufrimiento humano no se agota en los bordes de la piel del individuo. Como sostiene LALANGUE en su marco epistemológico, la subjetividad se teje inexorablemente en el campo del Otro.

Ante síntomas que se resisten a la dialectización (dolores mudos, repeticiones inquebrantables y angustias sin nombre), la Dra. VMG propone el **Enfoque Trifocal del Trauma**.

Este modelo no es una mera suma de teorías, sino un abordaje integrativo de la complejidad que nos permite mirar al ser humano como un sistema abierto, atravesado por múltiples capas de historia y biología.

El enfoque trifocal sostiene que para comprender la herida de un sujeto, debemos indagar simultáneamente en tres dimensiones interconectadas: el **Foco Individual**, el **Foco Sistémico** y el **Foco Colectivo**.

2. La arquitectura del Modelo Trifocal: Círculos concéntricos de afectación

La Dra. VMG utiliza una cartografía visual para explicar esta intersección.

Imaginemos tres círculos concéntricos que representan los tres focos. En cada uno de ellos, operan tres dimensiones constitutivas del ser humano: la **Mente (M)**, la **Emoción (E)** y el **Cuerpo (C)**.

- **El Foco Individual (FI):** Se centra en la biografía singular del sujeto. Abarca desde la vida intrauterina y el neurodesarrollo hasta sus experiencias de vida actuales.
- **El Foco Sistémico (FS):** Investiga la trama vincular inmediata y las lealtades invisibles que ligan al sujeto con su sistema familiar a través de las generaciones.
- **El Foco Colectivo (FC):** Analiza el impacto de eventos históricos, sociales y culturales —guerras, dictaduras,

pandemias— y sus herencias epigenéticas.

Como se señaló en el primer encuentro, habitamos un mundo donde se nos impulsa a alejarnos de la "sensación sentida".

El lenguaje del cuerpo es el que menos habitamos, pero es el que guarda la verdad del trauma.

Por ello, la escucha analítica debe ampliarse para incluir el registro somático, transitando el camino inverso: desde la sensación hacia la palabra.

3. Foco Individual: Cristalización de la biografía temprana

Llegamos al mundo con un par de lentes que ya vienen cargados por las experiencias de nuestros padres. El foco individual comienza incluso antes del nacimiento.



La Dra. VMG destaca que la vida intrauterina es un periodo de extrema vulnerabilidad donde el estrés materno puede dejar huellas indelebles .

Caso Clínico: La inmovilidad como memoria somática

Durante las clases, se expuso el caso de una paciente que consultaba por temas de alimentación y una profunda desconexión corporal.

En una de las sesiones, la paciente entró en un estado de **hipoactivación**, sintiendo paulatinamente como su cuerpo iba adormeciéndose.

Al profundizar, emerge un relato familiar de cuando su madre cursaba los siete meses del embarazo de ella. Sufren un robo violento donde su madre es encerrada en un placard mientras golpean al padre, amenazándolo de muerte .

La bebé -que hasta entonces se movía normalmente- deja de hacerlo desde ese evento hasta su nacimiento.

La madre incluso, comienza a acudir a urgencias pensando que la bebé está muerta, ya que no percibe sus movimientos.

La paciente había entrado en la misma respuesta de hipoactivación que su madre, una respuesta intrauterina de defensa parasimpática, recurso para sobrevivir al peligro externo del robo. Esa "inmovilidad" persiste como síntoma cincuenta años después.

Este caso ilustra una memoria traumática donde el testigo que podía nombrar lo ocurrido, era el cuerpo: el recuerdo es puramente somático; no hay palabra ya que en la etapa intrauterina no existe la representación simbólica, pero el cuerpo guarda la inteligencia del recurso defensivo arcaico de inmovilidad.

4. Foco Sistémico: Las lealtades invisibles y el libro contable familiar

Estamos hechos de historias. Algunas historias fueron relatos y otras, secretos. De estas historias, contadas o no, surgen dinámicas sistémicas: identificaciones, lealtades, implicancias, compensaciones

Aquello horroroso, imposible de comunicar queda escindido de la conciencia. Así el trauma sistémico se nutre de lo que se hereda sin que medie la voluntad consciente. Iván Boszormenyi -Nagy, citado como autor de referencia, introduce la noción de **lealtades invisibles**.



Los sistemas familiares poseen una arquitectura compleja: en su trasfondo inconciente operan fuerzas ordenadoras que registran deudas, culpas y méritos generacionales y los traducen en síntomas sufrientes o pulsos vitales y expansivos... Todos tenemos acceso al libro contable familiar, y todos tenemos un libro de referencia al que estamos vinculados tanto en las deudas como en los haberes.

Este territorio se entrelaza con los conceptos de **cripta y fantasma** de Abraham y Torok. Lo que una generación calla por dolor o vergüenza (**lo indecible**), en la segunda se vuelve **innombrable** y en la tercera **impensable**.

El fantasma es el material traumático que circula en las generaciones y termina siendo destino clínico.

Caso Clínico: El pedido de ir a la cárcel

Se mencionó el ejemplo de un niño preadolescente adoptado por una familia monoparental, que comenzó a presentar conductas que alarmaban a su madre: se bajaba del auto para jugar con niños de la calle, leía obsesivamente noticias sobre presos y pedía ir a una cárcel.

Al investigar el origen biológico silenciado, la madre descubrió que el padre biológico estaba efectivamente preso por robo. El síntoma del niño no era una falla individual, sino la expresión de una lealtad invisible hacia un padre innombrable.

Cuando la verdad fue integrada en el relato, el síntoma cedió, permitiendo que el joven se calmara y desarrollara su propia identidad. Esto confirma que lo no dicho estructura la patología y que la palabra es la vía de desanudamiento.

5. Foco Colectivo: El eco de la historia en el cuerpo

El tercer nivel de afectación es el trauma colectivo o histórico. Los seres humanos no somos islas; estamos inmersos en la herida abierta de nuestro pueblo. El trauma colectivo ocurre dentro de un grupo que vive una experiencia abrumadora con distintos gradientes. Las huellas de guerras, hambrunas,

migraciones forzadas y dictaduras quedan en nosotros como un alerta de base que condiciona nuestra biología.

Caso Clínico: La culpa del sobreviviente y Malvinas



Un hombre de 60 años consulta por reiteradas pesadillas de peligro inminente que no logra asociar con su presente cotidiano. En el proceso, emerge el recuerdo de un amigo que fue a la Guerra de Malvinas, mientras el paciente se "salvó" de ir.

El terror de sus pares se inscribió en su propio psiquismo a través de la **culpa del sobreviviente**. Su síntoma era la convergencia entre un trauma biográfico infantil (un accidente de su padre) y el trauma histórico de toda una generación argentina.

El impacto de traumas sociales recientes como la pandemia de COVID-19 y las huellas permanecen en mecanismos de hipervigilancia o ansiedad social que no se resuelven solo porque el evento pasó. El trauma colectivo requiere espacios grupales para que la carga se distribuya y el procesamiento sea posible.

6. Epigenética: El sustrato biológico de la transmisión

¿Cómo viaja esta información entre los focos?

La investigación actual sugiere que la exposición a estrés intenso o crónico puede alterar la regulación del Sistema Hipotalámico Hipófiso Adrenal (HHA) y asociarse con modificaciones epigenéticas, especialmente cambios en la metilación del ADN y en otros mecanismos reguladores de la expresión génica, sin modificar la secuencia del ADN (Turecki & Meaney, 2016).

Distintos estudios observacionales en humanos, han hallado asociaciones entre trauma parental o exposición prenatal adversa y variaciones endocrinas o epigenéticas en la descendencia, como se describió en sobrevivientes del Holocausto, en embarazos expuestos a los atentados del 11 de septiembre y en personas concebidas durante la Hambruna Holandesa (Yehuda et al., 2005; Yehuda et al., 2016; Heijmans et al., 2008).

Se citaron estudios emblemáticos:

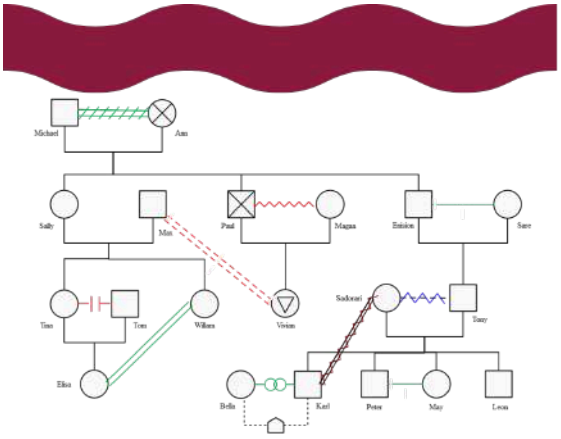
En uno de los estudios humanos más citados sobre programación prenatal y persistencia de marcas epigenéticas (Heijmans et al., 2008), en las madres embarazadas expuestas a los ataques del 11 de septiembre, se observaron niveles más bajos de cortisol en bebés de madres que desarrollaron PTSD. Este estudio muestra una asociación endocrina temprana vinculada al trauma materno durante la gestación (Yehuda et al., 2005).

En Heijmans et al. (2008) hallaron menor metilación del gen improntado IGF2 en adultos expuestos prenatalmente a la Hambruna Holandesa (1944-1945), en

comparación con sus hermanos del mismo sexo no expuestos.

7. El Genograma como herramienta diagnóstica y analítica

Para abordar esta complejidad, el clínico debe trabajar con el **genograma**.



No es un ejercicio de recolección de nombres, sino un acto analítico para hacer emerger la voz de los silenciados. Los vacíos en la narrativa familiar son indicadores sugestivos de trauma trifocal.

Allí donde el paciente ignora su origen o repite fracasos económicos, el genograma suele revelar migraciones forzadas o ancestros que perdieron todo.

Como señala la Dra. VMG, aportar esta información a la conciencia, aunque implique crisis, restituye sentido a síntomas incomprensibles y habilita la libertad del deseo.

Conclusión del Capítulo II

La adopción del **Enfoque Trifocal** transforma la posición del analista. El síntoma ya no es visto como un error de la biología o una metáfora exclusiva de un conflicto pulsional, sino como el testimonio encarnado de una historia que busca resolución.

Este modelo ofrece gafas para leer el "subtítulo" de la clínica. Al integrar la neurobiología vincular con la dimensión transgeneracional y colectiva, reafirmamos que la resiliencia no es un rasgo del carácter, sino el resultado de un entramado donde la posibilidad de una conexión segura puede revertir la huella de la herida. En el próximo capítulo, profundizaremos en la fisiología de la defensa que sostiene estos estados biológicos.

CAPÍTULO III: LA FISIOLOGÍA DE LA DEFENSA Y LA TEORÍA POLIVAGAL

El cuerpo como archivo vivo de la supervivencia

Preguntas nodales del capítulo:

- *¿Cómo organiza el sistema nervioso autónomo nuestras respuestas ante lo inasimilable?*
- *¿De qué manera la Teoría Polivagal revoluciona la comprensión del vínculo y el trauma?*
- *¿Qué implica clínicamente que el cuerpo quede "inhibido" en una respuesta de defensa no completada?*

1. El sustrato biológico en el campo del Otro

Una premisa fundamental para la clínica psicoanalítica del siglo XXI, es comprender que el sujeto no desarrolla su psiquismo en un vacío existencial. Tal como sostiene el marco epistemológico de la Facultad LALANGUE, la subjetividad se teje inexorablemente en el campo del Otro.

El psiquismo humano no crece de manera aislada. Del mismo modo en que se desarrolla el tejido óseo con el simple aporte de nutrientes; requiere de un otro con el que se establece un lazo, amor y apego.

Por definición, somos seres vinculares y vinculantes. A esta sólida concepción psicoanalítica, hoy se suma el inestimable aporte de las neurociencias contemporáneas, las cuales no vienen a refutar la metapsicología, sino a otorgarle un sustrato biológico fascinante que amplía nuestra capacidad de intervención clínica.

Como señala la Dra. VMG, el cuerpo es un espacio de sensaciones que son información pura, donde no opera la resistencia en términos puramente cognitivos.

Si aprendemos a leer adecuadamente estas señales con el paciente, podemos encontrar las llaves hacia lugares de integración y comprensión que de otro modo permanecen vedados.

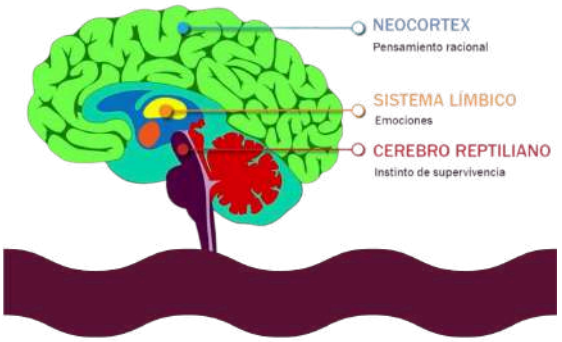
2. El Sistema Nervioso Autónomo: Vigilia, descanso y defensa

Nuestra biología está diseñada primariamente para la supervivencia. Poseemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico que actúan como el andamiaje de nuestra relación con el mundo. Dentro de este esquema, el **Sistema Nervioso Autónomo (SNA)** es el encargado de regular nuestras funciones involuntarias y nuestras respuestas ante el estrés.

Tradicionalmente, la medicina concebía al SNA como un sistema binario: el Simpático (lucha/huida) y el Parasimpático (descanso/digestión). Sin embargo, las investigaciones de las últimas décadas han revelado una complejidad mayor.

Como explica la Dra. VMG, el SNA es un sistema de vigilia y descanso que se activa automáticamente ante la percepción de amenaza.

Contamos con un sistema reptiliano disponible y activo, un sistema mamífero de defensa y nuestro cerebro cognitivo, que es la modalidad más actual y sofisticada. No obstante, ante el terror, el cerebro cognitivo suele quedar relegado, cediendo el mando a las respuestas biológicas más primitivas.



3. La Teoría Polivagal: La necesidad filogenética del otro

A diferencia de las concepciones cartesianas que reducían la salud a la ausencia de enfermedad orgánica en un individuo aislado, las nuevas teorías demuestran la influencia de los lazos de confianza en nuestra biología. En este terreno destaca la **Teoría Polivagal**, desarrollada por **Stephen Porges**.



Porges aporta evidencia sobre un desarrollo neurobiológico evolutivo propio de los mamíferos -cuyo elemento central es el **Nervio Vago**-, y que organiza jerárquicamente nuestras defensas en tres niveles:

a. La vía Vago Ventral (Conexión Social)

Es la vía más reciente y sofisticada. Actúa en contextos de seguridad y funciona como un auténtico interruptor (*switch-off*) que apaga el pánico y enciende la percepción de reparo. Es la base neurofisiológica de los vínculos saludables, la empatía y la comunicación. Esta vía se mieliniza en la primera infancia —especialmente en los primeros dos años— siempre que el bebé sea sostenido por un cuidado "suficientemente bueno", en términos de Winnicott.

b. El Sistema Simpático (Movilización)

Cuando la seguridad se quiebra, el organismo activa la **hiperactivación**. Es una inundación de energía que prepara al sujeto para la lucha o la huida. Se manifiesta con taquicardia, tensión muscular y dilatación de pupilas.

c. La vía Vago Dorsal (Inmovilización)

Es la vía más arcaica, compartida con los reptiles. Se activa ante una amenaza ineludible donde la lucha o la huida son imposibles, provocando la **hipoactivación**. El resultado es el congelamiento, la disociación masiva y la anestesia emocional.

4. Neurocepción: El escáner automático de seguridad

La **Neurocepción** se trata de un proceso inconsciente mediante el cual nuestro sistema nervioso escanea continuamente el entorno, los rostros y las voces para detectar señales de peligro.

Si la neurocepción capta seguridad, se habilita la rama ventral y el vínculo social. Pero si detecta peligro, el sistema se bifurca hacia la defensa simpática o el colapso dorsal.

En la clínica, esto es vital: si un paciente mira el rostro de su analista y encuentra un rostro apático o inexpresivo, su biología lee peligro o abandono,



activando la modalidad de alerta e impidiendo que las memorias somáticas emerjan.

5. La gramática de la naturaleza: El Oso y la Gacela

Para ilustrar estas activaciones, la Dra. VMG recurre a escenas de la naturaleza que resuenan en nuestras neuronas espejo .

El Oso Pequeño y el Puma (Hiperactivación)

En vivo, se proyectó un video donde un oso es perseguido por un puma. De solo observar la escena, experimentamos taquicardia y tensión. En los humanos, este estrés no requiere de un depredador carnívoro. Un adolescente que sufre exclusión social o burlas por internet experimenta un dolor psíquico que activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico, desencadenando una respuesta de hiperactivación idéntica a la de la supervivencia biológica.

La Gacela y la Hiena (Hipoactivación)

Otro video mostró a una gacela interceptada por una hiena. Ante la imposibilidad de escape, la gacela activa un estado de inmovilidad tónica, de muerte fingida. Lo hipoactivo de la tanatosis, anestesia el dolor y puede desestimular al predador, brindando una mínima oportunidad de huida si este se distrae.

En los humanos, este sistema sigue plenamente vigente. Lo experimentamos cuando nos quedamos "en blanco" rindiendo un examen o cuando quedamos paralizados ante una agresión sin poder reaccionar. Tales mecanismos defensivos son una respuesta fisiológica involuntaria, distinta de un "acting" consciente: no tenemos injerencia consciente para frenarlos

6. Peter Levine y la respuesta inhibida

La comprensión del trauma ha sido revolucionada por **Peter Levine**, creador de *Experiencia Somática*.



Levine observa que, en contextos traumáticos, el cuerpo queda frecuentemente **inhibido** en una respuesta de supervivencia.

Imaginemos a una persona que sufre un robo. En las milésimas de segundo previas al colapso, el sistema evaluó opciones: "¿Y si me escapo? ¿Puedo luchar?". Todos esos impulsos movilizaron una energía inmensa en el sistema simpático. Pero si el sistema decidió que lo más seguro era congelarse, esa energía quedó sepultada debajo del "manto pesado" del vago dorsal.

Para mantener a raya esos impulsos truncados, el psiquismo utiliza una fuerza vital gigantesca como mecanismo de desconexión.

El sujeto sobrevive, pero queda atrapado en una inmovilidad crónica, pagando el costo de la fatiga, la somatización y la depresión. Los síntomas que aparecen después son, en realidad, intentos del organismo por traer esa escena traumática al presente para resolver lo que quedó pendiente.

7. El proceso clínico: Del congelamiento a la descarga

El trabajo clínico con el trauma exige encontrarse primero con estas respuestas masivas de congelamiento.

Como se discutió en el grupo de estudio, no es posible forzar el proceso; se requiere de un espacio terapéutico seguro donde la **corregulación** permita que el sistema nervioso del paciente empiece a flexibilizarse.

Cuando el paciente comienza a "descongelarse", suelen irrumpir en sesión las ganas de luchar que quedaron inconclusas. Aparece una rabia enorme, los puños se tensan y el rostro se endurece. Es el registro somático de una acción que no tuvo lugar en el pasado, pero que clama por completarse en el presente.

Al permitir que estas respuestas circulen y se completen en la seguridad del consultorio, se reconectan la sensación corporal con la emoción y con el pensamiento: ¿Qué fue lo que me pasó?

8. La corregulación como herramienta ética

Para establecer este marco de seguridad, el terapeuta debe estar dispuesto a "sentirse a sí mismo" y a prestar su propia presencia somática como un ancla biológica. La corregulación es límbica: es nuestro sistema vagal maduro ofreciendo calma a un sistema desregulado.



Lorena Salthu subraya que este enfoque no va en contra del formato psicoanalítico, sino que lo amplía: “Se puede ser fiel al dispositivo y sumar estas nuevas formas de lectura que nos permiten ver cómo el inconsciente y el cuerpo están integrados.”

Conclusión del Capítulo III

Integrar la fisiología de la defensa en la escucha clínica nos permite transformar el síntoma mudo en una narrativa historizable.

Hemos comprendido que el síntoma es un mensajero de una historia interrumpida y que la inmovilidad no es una falla de carácter, sino un recurso evolutivo arcaico.

Como sostiene la Dra. VMG, "en la herida está la cura": el trabajo con el trauma es gratificante porque, al generar condiciones de confianza, permitimos que las personas atraviesen sus experiencias más temidas para alcanzar estados de mayor autenticidad, benevolencia, humanidad y salud.

Una vez que el sistema nervioso recupera su flexibilidad, el paciente puede finalmente relacionarse con su historia y gestionar de un modo más adulto, su presente.

CAPÍTULO IV: LA TRAMA TRANSGENERACIONAL Y EL TRAUMA SISTÉMICO

El legado de lo no dicho y las lealtades invisibles

Preguntas nodales del capítulo:

- *¿De qué manera el sujeto se constituye como el eslabón de una cadena de transmisiones inconscientes?*
- *¿Cómo operan la "cripta" y el "fantasma" en la formación de síntomas inexplicables para la biografía individual?*
- *¿Qué función cumplen las lealtades invisibles en la repetición de destinos traumáticos?*

1. El ser humano como eslabón generacional

Para la clínica psicoanalítica estructural, es una premisa ineludible comprender que el ser humano no adviene al mundo como una página en blanco.

Existe como individuo singular pero, de manera simultánea e ineludible, es el eslabón de una extensa cadena generacional que cumple (muchas veces sin su voluntad consciente) los objetivos del grupo y de la especie.

Desde el psicoanálisis, entendemos que existe un imperativo psíquico por transmitir, un impulso profundamente arraigado en la pulsión de conservación y de continuidad de la vida (Eros). Esta pulsión constituye el andamiaje del inconsciente hereditario.

Como se discutió en el seminario, no se trata de una herencia "esotérica", sino de la forma en que el Ello se construye a partir de los fragmentos de vida psíquica de los progenitores.

Sigmund Freud, en obras como *Tótem y Tabú,* y *Moisés y la religión monoteísta*, fue categórico al afirmar que la herencia arcaica del ser humano está conformada por fragmentos de origen filogenético aportados con el nacimiento.

Sin embargo, esta herencia no se recibe pasivamente; requiere del sujeto el inmenso trabajo de hacerla propia.

Es precisamente en los fallos, en las interrupciones y en los silencios de esta transmisión donde anidan los cuadros clínicos más complejos que recibimos en la actualidad.

2. Lo indecible, lo innombrable y lo impensable

Para que el material psíquico de las generaciones anteriores pueda ser asimilado, debe existir un aparato capaz de "digerirlo". Wilfred Bion definió con

precisión este proceso a través de la **capacidad de *rêverie* materna**: la disposición psíquica de la madre para acoger las proyecciones de angustia del bebé (**elementos beta**) y transformarlas en pensamientos tolerables (**elementos alfa**).

¿Qué sucede cuando la madre, portadora de sus propios traumas no elaborados, presenta fallas en esta capacidad?

Al no poder contener estas proyecciones, se produce una transmisión directa de elementos no representables, denominados "objetos enquistados o inertes".

Retomando los aportes de René Kaës, observamos una degradación trans-generacional del sentido: lo que en una primera generación fue un acontecimiento **indecible** (por dolor o vergüenza), en la segunda se transforma en algo **innombrable**, y al llegar a la tercera generación deviene absolutamente **impensable**.

En la práctica clínica, este fenómeno se manifiesta cuando un paciente relata angustias "sin nombre" o síntomas corporales que carecen de toda lógica dentro de su propia biografía.



El dolor que no encontró palabras en el pasado utiliza el cuerpo del descendiente contemporáneo como su único teatro de operaciones posible.

3. La Cripta y el Fantasma: Los secretos encriptados

En el seno del inconsciente familiar, los procesos traumáticos no elaborados pueden generar tensiones entre el deseo de saber y la necesidad de pertenecer al grupo.

En este marco, los psicoanalistas Nicolas Abraham y María Torok desarrollaron una conceptualización central para pensar la transmisión psíquica de lo no elaborado, a través de las nociones de **cripta** y **fantasma** (Abraham & Torok, 1987).

La **cripta** refiere a un enclave intrapsíquico constituido cuando un duelo, un secreto o una experiencia vergonzosa no pueden ser simbolizados ni elaborados. En lugar de ser metabolizado, ese contenido queda “incorporado” y encapsulado en el aparato psíquico, fuera de los circuitos de representación (Abraham & Torok, 1987).

El **fantasma** designa la manifestación transgeneracional de ese material no elaborado. No se trata de la transmisión de un recuerdo consciente, sino de la emergencia, en el descendiente, de formaciones psíquicas (afectos, conductas, inhibiciones o síntomas) que remiten a una historia que no le fue narrada, pero que opera inconscientemente en su vida psíquica (Abraham & Torok, 1987).

En este sentido, el sujeto puede verse habitado por conflictos que no se inscriben en su biografía directa, sino en la economía psíquica de generaciones anteriores. Tal como señalan Abraham y Torok, se trata de “secretos enterrados”

que retornan bajo formas indirectas, produciendo efectos clínicos sin representación consciente.

Desde el enfoque trifocal, estos contenidos no simbolizados pueden pensarse como núcleos de lo no metabolizado que retornan en el cuerpo, en la repetición o en dificultades en el aprendizaje y la simbolización, sin que ello implique una transmisión lineal ni mecánica entre generaciones.



4. Justicia transgeneracional y lealtades invisibles

Esta herencia silenciada adquiere formas clínicas observables en la repetición de destinos, síntomas y elecciones vitales.

En este sentido, Iván Boszormenyi-Nagy desarrolló el concepto de **lealtades invisibles**, entendidas como vínculos éticos inconscientes que ligan al sujeto con su sistema familiar a través de obligaciones, deudas y mandatos no explicitados (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973/2008).

Desde esta perspectiva, los sistemas familiares pueden pensarse como organizados en torno a una suerte de **"contabilidad relacional"**, donde se registran méritos, injusticias, deudas y compensaciones entre generaciones. Estas dinámicas no operan en el plano consciente, se transmiten como exigencias de reparación o de equilibrio que el sujeto encarna sin saberlo.



De este modo, ciertos comportamientos repetitivos, elecciones fallidas o sufrimientos persistentes pueden comprenderse no sólo como conflictos intrapsíquicos, en aras de restaurar una justicia relacional en el sistema familiar (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973/2008).

Caso clínico: La lealtad al linaje biológico

Un caso trabajado en el marco del seminario permite ilustrar la potencia de estas dinámicas.

Se trataba de un niño preadolescente adoptado que comenzó a presentar conductas que preocupaban a su entorno: descendía del automóvil para vincularse con niños en situación de calle, mostraba un interés insistente por noticias vinculadas a personas privadas de libertad y manifestaba el deseo de visitar una cárcel.

En la indagación sistémica, la madre investiga la historia gestacional de los progenitores y descubre que el padre biológico del niño efectivamente, se encuentra privado de la libertad por delitos vinculados al robo.

Desde la lectura clínica, estos comportamientos podrían comprenderse como la expresión de una **lealtad invisible hacia un origen no simbolizado**, en la cual el niño encarna, sin saberlo, aspectos de una historia excluida del relato familiar.

La intervención consistió en introducir progresivamente la verdad de su origen dentro de un marco simbólico posible. Este proceso permitió una reorganización subjetiva: al historizar aquello que operaba en lo innombrable, el síntoma perdió su función organizadora, habilitando el despliegue de recursos identificatorios más ligados al entorno adoptivo.

Este caso ilustra cómo la inclusión simbólica de lo excluido puede operar como una forma de **reparación psíquica**, reduciendo la necesidad de repetición sintomática.

5. El cuerpo como registro de lo no tramitado

En la clínica contemporánea, resulta cada vez más evidente que aquello que no logra inscribirse en la cadena significante encuentra vías de expresión en el cuerpo.

Diversos desarrollos en psicoanálisis y psicosomática han señalado que el cuerpo puede funcionar como escenario de inscripción de lo no simbolizado (McDougall, 1989).

En esta línea, puede pensarse que cuando falla la mediación simbólica, se produce un pasaje directo entre lo inconsciente y el registro somático.

Este fenómeno se manifiesta en una amplia gama de expresiones clínicas (contracturas, trastornos digestivos, cefaleas, entre otros) que no siempre encuentran explicación suficiente en la historia consciente del sujeto.



Desde una perspectiva integrativa, el síntoma corporal no constituye únicamente una disfunción orgánica, sino también una **forma de inscripción de la experiencia no tramitada**, que requiere ser leída en articulación con la historia subjetiva y vincular.

La perspectiva de Dolto

Françoise Dolto, en su trabajo clínico con niños, subrayó la importancia del lugar de la palabra en la estructuración subjetiva.

En múltiples casos, observó que síntomas severos (incluyendo cuadros psicóticos) podían estar ligados a secretos familiares no simbolizados, como duelos ocultos o experiencias no nombradas (Dolto, 1984).

Cuando estos contenidos eran puestos en palabras en un contexto terapéutico, se observaban modificaciones significativas en la organización psíquica del niño. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que el síntoma infantil puede funcionar como portador de una verdad no dicha en el sistema familiar.

En este sentido, la palabra no sólo tiene valor comunicativo, sino también una función estructurante: permite transformar lo no representado en experiencia psíquicamente elaborable.

6. La brújula del genograma

Frente a la complejidad de estas dinámicas, el genograma se constituye como una herramienta clínica de gran valor. Más que un registro descriptivo, se trata de un dispositivo analítico que permite visibilizar patrones de repetición, vacíos narrativos y eventos significativos en la historia familiar (McGoldrick, Gerson & Petry, 2008).

En la práctica, es frecuente que los pacientes presenten relatos fragmentarios o generalizaciones defensivas sobre su origen (por ejemplo, “todos venimos de Italia”) que encubren zonas de desconocimiento o silenciamiento. Estos vacíos pueden ser indicadores de eventos traumáticos, migraciones forzadas o rupturas vinculares no elaboradas.

La exploración de estas discontinuidades permite reconstruir el contexto en el que se originan ciertos mandatos o creencias, facilitando su posterior elaboración.

De este modo, el genograma opera como una **brújula clínica** para orientar la lectura del síntoma en relación con la historia transgeneracional.



7. Vocación y reparación transgeneracional

Las elecciones vocacionales también pueden inscribirse en esta lógica de transmisión y reparación.

Diversos autores han señalado que ciertas profesiones pueden expresar intentos inconscientes de elaborar o compensar experiencias traumáticas del sistema familiar (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973/2008).

En la práctica clínica, es posible observar cómo algunos sujetos se orientan hacia profesiones de cuidado, riesgo o exposición al sufrimiento (como la medicina intensiva o la enfermería) en una dinámica que puede vincularse con la historia de pérdidas o traumas no elaborados en generaciones previas.

Sin reducir la vocación a una determinación transgeneracional, esta perspectiva permite ampliar su comprensión, incorporando las dimensiones histórica y vincular en la construcción del deseo profesional.

Conclusión del Capítulo IV

El recorrido por la faceta sistémica permite comprender que el pasado no constituye un elemento clausurado, sino una presencia activa que incide en la organización psíquica actual.

Las repeticiones, los síntomas y las elecciones vitales pueden leerse como intentos de elaboración de aquello que no ha encontrado simbolización en generaciones anteriores.

La tarea clínica consiste en crear las condiciones para que estos contenidos puedan ser historizados, es decir, inscriptos en la palabra y en la trama simbólica del sujeto.

Este proceso no elimina el pasado, pero al transformar el modo en que está presente, reduce su carácter compulsivo.

En este sentido, la intervención terapéutica no sólo tiene efectos individuales, sino también sistémicos: al interrumpir la transmisión de lo no elaborado, habilita en las nuevas generaciones una mayor libertad en la construcción de su propia historia.

CAPÍTULO V: EPIGENÉTICA TRANSGENERACIONAL Y PLASTICIDAD

La memoria molecular del trauma y el potencial de cambio

Preguntas nodales del capítulo:

- ¿Cómo se inscribe la historia colectiva y familiar en la biología individual sin alterar el código genético?
- ¿Qué mecanismos moleculares explican que el trauma de los abuelos se manifieste en la salud de los nietos?
- ¿De qué manera la psicoterapia puede actuar como un agente de cambio biológico a través de la plasticidad epigenética?

1. El ADN no es el destino: Una nueva frontera clínica

Durante décadas, el paradigma biomédico sostuvo una visión relativamente determinista del genoma, entendiendo al ADN como una estructura estable que condiciona de manera predominante las predisposiciones biológicas.

Sin embargo, el desarrollo de la epigenética ha introducido un cambio de perspectiva fundamental, al demostrar que la expresión génica puede ser modulada por factores ambientales y experiencias vitales sin alterar la secuencia del ADN (Meaney & Szyf, 2005; Turecki & Meaney, 2016).

En este marco, la epigenética puede ser pensada como una interfaz biológica entre organismo y ambiente, particularmente sensible a experiencias de estrés temprano, trauma y condiciones vinculares.

Para la clínica contemporánea, esto implica que el sujeto no sólo hereda un código genético, sino también patrones de regulación biológica influenciados por su historia relacional y, potencialmente, por la de sus progenitores.

Desde el enfoque trifocal, esta perspectiva permite articular la dimensión simbólica de la transmisión psíquica con un sustrato biológico plausible, sin reducir una a la otra.

2. Mecanismos moleculares: Metilación y regulación génica

Los mecanismos epigenéticos incluyen procesos como la metilación del ADN, las modificaciones de histonas y la regulación por ARN no codificante, todos ellos implicados en la modulación de la expresión génica (Turecki & Meaney, 2016).

La **metilación del ADN** consiste en la adición de grupos metilo a regiones

específicas del genoma, lo que puede reducir o inhibir la expresión de determinados genes. Este proceso no altera la secuencia genética, pero sí modifica su actividad funcional.

Diversos estudios han mostrado que experiencias de estrés crónico o adversidad temprana pueden asociarse con cambios en estos mecanismos, particularmente en genes vinculados a la regulación del eje hipotálamo–hipófiso–adrenal (HHA), implicado en la respuesta al estrés (Meaney & Szyf, 2005).

3. La herencia somática: Alcances y límites de la evidencia



La posibilidad de que experiencias traumáticas puedan influir en la biología de la descendencia, ha sido objeto de creciente investigación. En humanos, la evidencia disponible sugiere la existencia de **procesos de transmisión inter-generacional del estrés**, aunque los mecanismos precisos —incluyendo el rol de la epigenética— continúan siendo objeto de debate (Horsthemke, 2018; Zhou & Ryan, 2023).

Sobrevivientes del Holocausto

Yehuda et al. (2016) encontraron asociaciones entre la exposición parental al Holocausto y patrones de metilación del gen FKBP5 en sobrevivientes y sus descendientes. Este hallazgo ha sido interpretado como evidencia de efectos intergeneracionales del trauma.

El estudio del 11 de septiembre

En mujeres embarazadas expuestas a los atentados del 11 de septiembre, Yehuda et al. (2005) observaron que los bebés de madres que desarrollaron trastorno de estrés postraumático presentaban niveles más bajos de cortisol.

Este estudio constituye una evidencia relevante de **programación prenatal del estrés**, mostrando cómo el ambiente intrauterino puede influir en la regulación neuroendocrina del recién nacido.

La Hambruna de Holanda

Heijmans et al. (2008) demostraron que individuos expuestos prenatalmente a la Hambruna Holandesa presentaban diferencias persistentes en la metilación del gen IGF2 en comparación con sus hermanos no expuestos.

Este es uno de los estudios más robustos en humanos sobre efectos epigenéticos asociados a condiciones ambientales tempranas.

Ex prisioneros de guerra

Costa (2021) encontró una asociación entre el cautiverio severo de ex prisioneros de guerra y menor longevidad en sus descendientes masculinos. La autora señala que estos resultados son compatibles con efectos biológicos intergeneracionales, aunque no

constituyen una prueba directa de transmisión epigenética.

En conjunto, estos estudios sugieren que experiencias extremas pueden dejar huellas biológicas que se expresan en la descendencia. No obstante, en humanos, resulta metodológicamente complejo segregar los efectos epigenéticos de otros factores como la crianza, el ambiente social o la transmisión psicológica (Horsthemke, 2018).

4. La clínica del síntoma y el mapa epigenético

En la práctica clínica, estas posibles transmisiones no se presentan como datos biológicos aislados, sino bajo la forma de síntomas, creencias y patrones vinculares.

El síntoma somático puede ser comprendido, en esta perspectiva, como una forma de inscripción de experiencias que no han podido ser simbolizadas (McDougall, 1989).

Desde el **enfoque trifocal**, el síntoma no se reduce a una disfunción orgánica ni a un conflicto intrapsíquico aislado, más bien puede ser leído como el punto de convergencia entre la historia individual, vincular y colectiva.

Sin embargo, es importante evitar una lectura lineal en la que el síntoma sea interpretado directamente como consecuencia de una "marca epigenética".

La relación entre experiencia subjetiva, regulación fisiológica y mecanismos moleculares es compleja y no puede inferirse automáticamente en la clínica individual.



Articulación con Bion y Winnicott

Desde el psicoanálisis, la falla en la función de rêverie (Bion, 1962) implica la imposibilidad de transformar experiencias emocionales crudas en pensamientos elaborables.

Estos contenidos no simbolizados pueden persistir como núcleos de lo no metabolizado en el aparato psíquico.

En un enfoque integrativo, los desarrollos epigenéticos pueden ser pensados como un nivel complementario de análisis para comprender la persistencia de estas huellas, sin establecer una equivalencia directa entre conceptos metapsicológicos y mecanismos biológicos.

5. Plasticidad y cambio

Uno de los aportes más relevantes de la epigenética es la noción de plasticidad.

A diferencia de una visión determinista, los procesos epigenéticos son dinámicos y potencialmente reversibles en ciertos contextos (Meaney & Szyf, 2005).

Estudios recientes sugieren que algunas intervenciones psicoterapéuticas pueden

asociarse con cambios en marcadores epigenéticos en determinados trastornos, como el estrés postraumático o los trastornos de ansiedad (Massoni, 2024).

Sin embargo, esta evidencia heterogénea es aún incipiente. En este sentido, puede afirmarse que la psicoterapia favorece procesos de regulación del estrés, integración emocional y reorganización subjetiva que podrían tener correlatos biológicos, sin que ello implique afirmar una reversión directa y universal de "marcas epigenéticas del trauma".



Conclusión del Capítulo V

La epigenética introduce una perspectiva que complejiza la comprensión del trauma, al mostrar que la biología no es un destino fijo, sino un sistema dinámico en interacción con la experiencia.

Desde el enfoque trifocal, esta dimensión permite articular la transmisión psíquica, vincular y colectiva con procesos biológicos, sin reducir unos a otros.

La tarea clínica no consiste en "modificar directamente la biología", sino en generar condiciones de simbolización, regulación y vínculo que permitan al sujeto reorganizar su experiencia y disminuir la compulsión a la repetición.

En este sentido, la posibilidad de cambio no radica en borrar la huella del trauma, sino en transformarla en una experiencia integrable dentro de la historia del sujeto.

CAPÍTULO VI: DERIVACIONES PRÁCTICAS Y CLÍNICA DE LA SABIDURÍA

De la herida a la integración evolutiva

Preguntas nodales del capítulo:

- ¿Cómo se traduce el enfoque trifocal en la intervención clínica cotidiana dentro del consultorio?
- ¿Qué lugar ocupa el cuerpo del analista como herramienta de corregulación en la transferencia?
- ¿De qué manera la "lectura de los subtítulos" de la clínica habilita la interrupción de la repetición transgeneracional?
- ¿Qué define el concepto de "sanar" desde una perspectiva que integra la inteligencia evolutiva del trauma?

1. La praxis clínica en el siglo XXI: El analista como detector de señales

El ejercicio clínico contemporáneo nos exige una posición ética y técnica que trascienda la mera escucha de la palabra.

Como hemos analizado, en casos de trauma severo o transmisiones "impensables", el discurso consciente suele ser insuficiente o, en ocasiones, retraumatizante.

Por ello, la propuesta de la Facultad LALANGUE es la de un analista que opera con una **atención flotante ampliada** hacia el lenguaje del soma.

¿Cómo integramos las "lupas" del enfoque trifocal en la sesión?

La práctica analítica debe incluir tres dimensiones de observación simultáneas:

1. **Foco Individual:** Atender a las heridas fundantes de la biografía temprana del sujeto y sus defensas estructurales.
2. **Foco Sistémico:** Identificar las lealtades invisibles, los secretos de familia y los "encargos" parentales que el sujeto cumple de manera inconsciente.
3. **Foco Colectivo:** Leer la marca de los eventos históricos masivos (guerras, dictaduras, pandemias) que actúan como "ruido de base" en el psiquismo del paciente.

El **genograma** es una herramienta analítica profunda, que trasciende la mera recolección de datos y coadyuva en comprender la dinámica/estructura familiar hacia desanudar lo innombrable.

Al preguntar: ¿De dónde viene la familia? y toparnos con el silencio o lo desconocido, estamos ante la puerta de la "cripta" o el "fantasma" que requiere ser historizado para que el síntoma ceda.

2. El cuerpo en la transferencia: La corregulación como motor de la cura

Una de las derivaciones más potentes de la **Teoría Polivagal** aplicada a la clínica es el reconocimiento del sistema nervioso del terapeuta como un agente activo en el proceso de cura.



¿Por qué es necesaria la presencia vago-ventral del analista?

El sistema nervioso del paciente traumatizado escanea permanentemente el entorno en busca de señales de seguridad o peligro (neurocepción). Si el analista sostiene un rostro inexpresivo o una distancia emocional excesiva, el paciente puede percibirlo como una amenaza, reforzando la disociación o la hipoactivación.

La **corregulación** es, por tanto, una herramienta ética:

- El analista debe estar dispuesto a "sentirse a sí mismo" para que el paciente pueda sentirse seguro.
- La conexión social (vía vago-ventral) actúa como un *switch-off* al pánico.
- Un espacio terapéutico seguro permite que las memorias somáticas —aquel frío intenso, el temblor o el adormecimiento— emerjan y se integren en la cadena significante sin desbordar el contenedor psíquico.

3. El proceso de "desanudar": Del congelamiento a la palabra

El trabajo clínico consiste en ayudar al paciente a completar aquellas respuestas de defensa que quedan inhibidas al momento del trauma. Cuando el sistema nervioso opta por el congelamiento o la muerte fingida para sobrevivir, una gran cantidad de energía vital queda atrapada en el cuerpo.

¿Cuál es la ruta clínica de la descarga?

1. **Reconocer la inmovilidad:** Validar el congelamiento como una respuesta inteligente de supervivencia del organismo ante una amenaza inmanejable.
2. **Habilitar la sensación sentida:** En lugar de buscar rápidamente el porqué racional, el analista invita a explorar el "cómo" se siente el cuerpo en el presente de la sesión.
3. **Facilitar la descarga somática:** Permitir el temblor, el bostezo, el calor o el cambio de postura que indica que el sistema nervioso está saliendo de la defensa parasimpática hacia un nuevo equilibrio.
4. **Simbolización:** Solo una vez que la carga biológica ha disminuido, la palabra significativa puede enlazar la sensación con la historia del pasado (propia o heredada).

4. El síntoma como inteligencia evolutiva

En la Facultad LALANGUE, dejamos de ver al síntoma como un enemigo para leerlo como un **mensajero de la historia**.

El trauma es una inteligencia que nos permitió seguir adelante a expensas de una fractura interna.

¿Cómo transformamos la herida en sabiduría?

La clínica de la sabiduría no busca retornar a una normalidad pre-traumática -lo cual es imposible, pues el pasado ya ha reescrito nuestra biología-, sino evolucionar a partir de la integración del dolor.

- **Historizar la lealtad:** Al reconocer que una conducta (como no poder parar de comer o no poder sostener un trabajo) es una compensación a una hambruna o pérdida sufrida por los ancestros, el paciente puede agradecer ese mecanismo de supervivencia sistémica y, a la vez, habilitarse a hacerlo diferente.
- **Habilitar la libertad del deseo:** La salud se recupera cuando el sujeto deja de ser prisionero de un destino repetitivo y comienza a habitar un presente con identidad propia.



5. Una nueva definición de Salud: La perspectiva vincular

La salud, desde esta praxis integrativa, no es la mera ausencia de enfermedad orgánica, sino una capacidad artesanal del sujeto.

¿Qué dimensiones componen la salud en el siglo XXI?

Inspirados en Pichón Rivière y en los aportes teórico-clínicos de la Dra. VMG, quien define la salud como la posibilidad de:

- Estar en relación con uno mismo, con el propio cuerpo y las emociones.
- Establecer lazos y relaciones de confianza con otros (corregulación).
- Atravesar situaciones desafiantes generando mayor resiliencia.
- Sostener un proyecto de vida propio y vocación que trascienda los encargos transgeneracionales.

Conclusión del Capítulo VI

Finalizar este recorrido nos devuelve a la metáfora de las "gafas" y las "lupas". El analista que se forma bajo este marco sabe que la clínica es una investigación permanente.

Al leer los subtítulos (lo pequeño, lo somático, lo silenciado en el genograma), abrimos puertas hacia la salud que de otro modo permanecen clausuradas.

Aunque este proceso implique atravesar crisis y tensiones, es la vía para interrumpir la transmisión patógena de lo impensable y habilitar la libertad del deseo en las nuevas generaciones

Al final, sanar es evolucionar, y esa evolución es siempre vincular.

CONCLUSIONES: HACIA UNA INTEGRACIÓN CLÍNICA EVOLUTIVA

El Psiquismo como Tejido Vincular y Biológico

Al finalizar este recorrido, resulta imperativo reconocer que el ser humano es, ante todo, un ser vincular cuya biología se despliega y se esculpe bajo la influencia constante de su vincularidad.

El psiquismo individual no constituye un origen autónomo ni surge de manera aislada; por el contrario, emerge de una **fusión primaria con el inconsciente materno** durante los primeros meses de vida, y con el inconsciente familiar global a lo largo de toda la existencia.

Para comprender la profundidad de esta premisa, debemos desplazar la mirada de una clínica centrada únicamente en el conflicto intrapsíquico hacia una que reconozca que el niño nace en un entramado de modelos vinculares y huellas de lo acontecido en la infancia de sus progenitores.

El **inconsciente materno** no es una entidad abstracta, sino una matriz relacional y biológica en la que el infante habita inicialmente.

Los lazos tempranos con los cuidadores formulan en el psiquismo del niño definiciones y modelos constituyentes de su subjetividad, convirtiendo su organismo en un cuerpo sentido y simbolizado.



Esta fusión primaria implica que la salud psicoafectiva de los referentes es fundamental, ya que el sistema nervioso del infante responde y se despliega biológicamente solo si existe una matriz de estímulo afectivo y contacto adecuado.

Cuando la madre (o el cuidador) porta traumas no elaborados, su capacidad de *rêverie* falla; es decir, no puede metabolizar las sensaciones crudas o **elementos beta** del bebé para transformarlos en pensamientos.

En consecuencia, lo que se transmite en esa fusión son "objetos enquistados", fragmentos de una historia traumática que el niño absorbe y que colonizan su epigenoma, pre-configurando su respuesta al mundo antes incluso de tener uso de la palabra.

La Dimensión Económica del Trauma

La relectura de la obra freudiana bajo el prisma de las neurociencias contemporáneas nos permite entender el trauma como una "olla de arroz" que desborda el contenedor psíquico.



El trauma no se define por la naturaleza objetiva del evento, sino por la relación entre el influjo de excitación y la capacidad de elaboración del aparato psíquico en un momento dado.

Cuando el psiquismo falla en su tarea de ligar las excitaciones, el dolor busca un escenario alternativo en el cuerpo.

La clínica que proponemos reconoce que aquello que no tiene espacio en la mente coloniza el soma en forma de síntomas mudos pero persistentes.

Las patologías psicosomáticas, hoy tan frecuentes, son vías anexas creadas en la infancia cuando no hubo un "otro" capaz de traducir las sensaciones en palabras adecuadas.

El analista del siglo XXI debe, por tanto, ampliar su atención flotante para captar los "subtítulos" de la clínica: el frío, el temblor y el adormecimiento que el cuerpo trae a la sesión como fragmentos de una historia no contada.

El Epigenoma: El Archivo de lo innombrable

Uno de los pilares más revolucionarios de este texto es la conceptualización de la epigenética como el registro biológico del campo del Otro.

Si bien el ADN es estable, el epigenoma funciona como un manual de instrucciones marcado por las vivencias de los ancestros.

La evidencia científica sistematizada en este volumen (desde los hijos del 11 de Septiembre hasta los descendientes del Holocausto y la hambruna de Holanda) demuestra que el estrés masivo de una generación deja marcas químicas (metilación) que pre-configuran el sistema de alerta de los descendientes.

Para el psicoanálisis estructural, esto explica por qué un sujeto puede presentar angustias que no se explican desde su propia biografía: se trata de elementos beta heredados, de pensamientos que no pudieron ser pensados por los padres y que regresan a través del síntoma corporal o el delirio.



La progresión de lo indecible a lo innombrable y finalmente a lo impensable es, en última instancia, un proceso de transmisión de "objetos enquistados" que el epigenoma preserva biológicamente.

La Ética de la Corregulación en el Dispositivo Analítico

La praxis clínica derivada de la Teoría Polivagal impone una nueva **responsabilidad ética** al analista.

El sistema nervioso del paciente escanea constantemente al terapeuta en busca de señales de seguridad. Sanar, en este contexto, requiere de un analista que reconozca que la corregulación es también límbica y vagal.

El espacio terapéutico debe ser un entorno seguro que actúe como un *switch-off* al pánico.

Solo a través de esta conexión social (vía vago-ventral) es posible que el sujeto se permita vivir sensaciones temidas en el aquí y ahora de la sesión, completando las respuestas de defensa inhibidas que lo mantienen atrapado en la repetición.



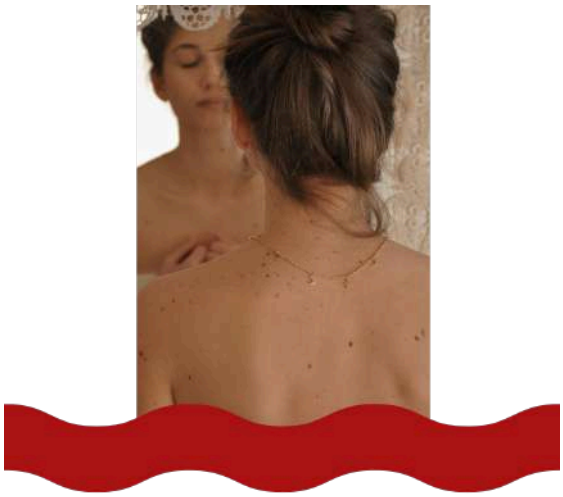
La Plasticidad como Horizonte de Esperanza

Frente al determinismo biológico o transgeneracional, se posiciona la **plasticidad** como el eje de la cura.

Los avances en investigaciones sobre epigenética dan cuenta de que la psicoterapia puede alterar (y potencialmente revertir) patrones epigenéticos de riesgo.

Al desanudar los secretos familiares y poner palabras a lo impensable, aliviamos al individuo, y puede ser posible modificar la herencia epigenética en ese sujeto y su descendencia.

Sanar no es volver a ser quienes éramos antes del trauma, sino que evolucionar a partir de lo vivido es desarrollar la capacidad artesanal de estar en relación con uno mismo y con los otros, de sostener un proyecto de vida y de integrar la herida como sabiduría evolutiva.



Al usar las lupas del enfoque trifocal, el terapeuta ayuda al paciente a diferenciar su identidad de los encargos y lealtades de su linaje.

Esta diferenciación es lo que habilita la libertad del deseo: la posibilidad de que cada sujeto, siendo el último eslabón de su cadena, pueda escribir su propia historia en el terreno fértil de una salud recuperada.

Reflexión Final

En conclusión, el abordaje de la salud y el trauma que hemos sistematizado propone un analista que sea, simultáneamente, un investigador de la historia colectiva, un desanudador de secretos sistémicos y un experto en la corregulación somática.

Al honrar la inteligencia evolutiva del síntoma y confiar en la plasticidad del sistema nervioso, abrimos una puerta hacia la cura que trasciende lo individual para sanar el tejido mismo de nuestra humanidad vinculada.

BIBLIOGRAFÍA

- Abraham, N., & Torok, M. (1987). *La corteza y el núcleo: El parentesco fantasmático*. Amorrortu.
- Bion, W. R. (1962). *Learning from experience*. Routledge.
- Bion, W. R. (1967). *Volviendo a pensar*. Paidós.
- Boszormenyi-Nagy, I., & Spark, G. M. (2008). *Lealtades invisibles: Reciprocidad en terapia familiar intergeneracional*. Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1973)
- Ceberio, M. (2017). *Los juegos del mal amor*. Ediciones B.
- Costa, D. L. (2021). *Health shocks of the father and longevity of the children's children* (NBER Working Paper No. 29553). National Bureau of Economic Research.
- Dolto, F. (1984). *La imagen inconsciente del cuerpo*. Paidós.
- Freud, S. (1913). *Tótem y tabú*. Amorrortu.
- Freud, S. (1920). *Más allá del principio del placer*. Amorrortu.
- Freud, S. (1939). *Moisés y la religión monoteísta*. Amorrortu.
- Heijmans, B. T., Tobi, E. W., Stein, A. D., Putter, H., Blauw, G. J., Susser, E. S., Slagboom, P. E., & Lumey, L. H. (2008). Persistent epigenetic differences associated with prenatal exposure to famine in humans. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 105*(44), 17046–17049. https://doi.org/10.1073/pnas.0806560105
- Horsthemke, B. (2018). A critical view on transgenerational epigenetic inheritance in humans. *Nature Communications, 9*, 2973. https://doi.org/10.1038/s41467-018-05445-5
- Hübl, T. (2021). *Sanar el trauma colectivo*. Gaia.
- Kaës, R., Faimberg, H., Enríquez, M., & Baranes, J. (1996). *Transmisión de la vida psíquica entre generaciones*. Amorrortu.
- Laplanche, J., & Pontalis, J.-B. (1996). *Diccionario de psicoanálisis*. Paidós.
- Levine, P. A. (2013). *Sanar el trauma*. Neo Person.
- Massoni, L. (2024). Epigenetic and mental diseases: The role of psychotherapy. *International Journal of Translational Medicine, 4*(3), 450–462. https://doi.org/10.3390/ijtm4030030
- McDougall, J. (1989). *Theaters of the body: A psychoanalytic approach to psychosomatic illness*. W. W. Norton.
- McGoldrick, M., Gerson, R., & Petry, S. (2008). *Genograms: Assessment and intervention* (3rd ed.). W. W. Norton.
- Meaney, M. J., & Szyf, M. (2005). Environmental programming of stress responses through DNA methylation. *Molecular Psychiatry, 10*(10), 846–858. https://doi.org/10.1038/sj.mp.4001732
- Molina Gerstner, V. (2026). *Familia, trauma y salud* [Manuscrito inédito]. Facultad LALANGUE.
- Porges, S. W. (2004). Neuroception: A subconscious system for detecting threat and safety. *Zero to Three, 24*(5), 19–24.
- Porges, S. W. (2007). The polyvagal perspective. *Biological Psychology, 74*(2), 116–143. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2006.06.009
- Porges, S. W. (2011). *The polyvagal theory: Neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication, and self-regulation*. W. W. Norton.
- Serebrinsky, H., & Rodríguez, S. (2014). *Diagnóstico sistémico*. Psicolibros.
- Turecki, G., & Meaney, M. J. (2016). Effects of the social environment and stress on glucocorticoid receptor gene methylation: A systematic review. *Biological Psychiatry, 79*(2), 87–96.

https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2014.11.022

- Wilker, S., Pfeiffer, A., Kolassa, S., Elbert, T., & Kolassa, I.-T. (2023). DNA methylation changes after psychotherapy in PTSD patients. *Translational Psychiatry, 13*, 63. https://doi.org/10.1038/s41398-023-02316-6
- Winnicott, D. W. (1965/1984). *The maturational processes and the facilitating environment*. Routledge.
- Yehuda, R., Engel, S. M., Brand, S. R., Seckl, J., Marcus, S. M., & Berkowitz, G. S. (2005). Transgenerational effects of PTSD in babies of mothers exposed to the World Trade Center attacks. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 90*(7), 4115–4118. https://doi.org/10.1210/jc.2005-0550
- Yehuda, R., Daskalakis, N. P., Bierer, L. M., Bader, H. N., Klengel, T., Holsboer, F., & Binder, E. B. (2016). Holocaust exposure induced intergenerational effects on FKBP5 methylation. *Biological Psychiatry, 80*(5), 372–380. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2015.08.005
- Zhou, A., & Ryan, J. (2023). Biological embedding of early-life adversity: A review of intergenerational epigenetic transmission. *Genes, 14*(8), 1639. https://doi.org/10.3390/genes14081639

GLOSARIO CONCEPTUAL

Definición articulada de términos clave

Capacidad de *rêverie*:

Concepto desarrollado por el psicoanalista Wilfred Bion que designa la disposición psíquica de la madre (o del analista, en el marco del dispositivo terapéutico) para acoger, contener y metabolizar las proyecciones de angustia intolerable o impresiones sensoriales brutas del infante (elementos beta). Al procesar este material, la madre lo devuelve transformado en pensamientos tolerables y susceptibles de ser mentalizados (elementos alfa), posibilitando así el desarrollo del aparato psíquico del niño.

Corregulación:

Capacidad biológica y relacional mediante la cual el sistema nervioso de un individuo se estabiliza a través de la presencia cálida, segura y empática de otro ser humano. Fundamentada en los desarrollos de la teoría polivagal, la corregulación es esencial durante la primera infancia, donde el infante depende del sistema nervioso maduro de sus cuidadores para regular su afecto. En la clínica del trauma, constituye una herramienta central para favorecer la seguridad y evitar la retraumatización.

Cripta y Fantasma (transgeneracional):

Conceptos desarrollados por Nicolas Abraham y María Torok para explicar fenómenos de transmisión psíquica en el ámbito familiar. La *cripta* refiere al encapsulamiento intrapsíquico de un secreto, un duelo no elaborado o una experiencia traumática no simbolizada. El *fantasma* designa la manifestación de ese contenido en la descendencia, a través de síntomas, afectos o conductas que no encuentran anclaje en la historia personal del sujeto, pero que remiten a una historia no elaborada en generaciones anteriores.

Elementos beta:

Término introducido por Bion que refiere a sensaciones en bruto, impresiones sensoriales o estados emocionales no metabolizados que no han sido transformados en pensamientos (elementos alfa) mediante la función de *rêverie*.

Epigenética:

Campo de la biología que estudia los mecanismos mediante los cuales factores ambientales y experiencias vitales —incluyendo el estrés— pueden modular la expresión génica sin alterar la secuencia del ADN. Estos procesos incluyen la metilación del ADN, las modificaciones de histonas y la regulación por ARN no codificante. En humanos, la relación entre experiencias psicológicas y cambios epigenéticos es compleja y no lineal. Su posible transmisión entre generaciones continúa siendo objeto de investigación.

Hiperactivación:

Respuesta de supervivencia mediada por el sistema nervioso simpático frente a una amenaza evaluada como afrontable. Se caracteriza por un aumento de la activación fisiológica que prepara al organismo para la lucha o la huida, manifestándose en taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, tensión muscular y dilatación pupilar.

Hipoactivación:

Mecanismo de defensa biológico arcaico, mediado por la rama dorsal del nervio vago. Se activa ante amenazas abrumadoras o ineludibles. Surge en

estados de congelamiento, disociación, anestesia emocional y disminución del tono vital.

Lealtades invisibles:

Concepto desarrollado por Iván Boszormenyi-Nagy que describe los vínculos éticos inconscientes que ligan al sujeto con su sistema familiar. Estas lealtades se organizan en torno a una "contabilidad relacional" de deudas, méritos e injusticias, y pueden expresarse en repeticiones de sufrimiento o en elecciones vitales orientadas a preservar la pertenencia al grupo.

Metilación del ADN:

Mecanismo epigenético mediante el cual se añaden grupos metilo a regiones específicas del ADN, modulando la expresión de ciertos genes. Este proceso no altera la secuencia genética, pero puede influir en su actividad funcional. En humanos, su relación con el trauma y su transmisión intergeneracional es un campo de investigación en desarrollo.

Neurocepción:

Concepto de la teoría polivagal que describe el proceso inconsciente mediante el cual el sistema nervioso evalúa continuamente el entorno en busca de señales de seguridad o peligro. Esta evaluación antecede a la cognición consciente y determina la activación de estados de conexión social, defensa o colapso.

Resiliencia:

Capacidad del individuo o del grupo para atravesar situaciones adversas y reorganizarse de manera adaptativa. Desde una perspectiva vincular, depende en gran medida de la calidad de los lazos afectivos y de la disponibilidad de entornos reguladores.

Teoría polivagal:

Modelo neurobiológico desarrollado por Stephen Porges que describe la organización jerárquica del sistema nervioso autónomo en tres circuitos: el sistema parasimpático dorsal (inmovilización), el sistema simpático (movilización) y el sistema parasimpático ventral (conexión social). Este último constituye la base neurofisiológica de los vínculos seguros y la regulación emocional.

Transmisión transgeneracional:

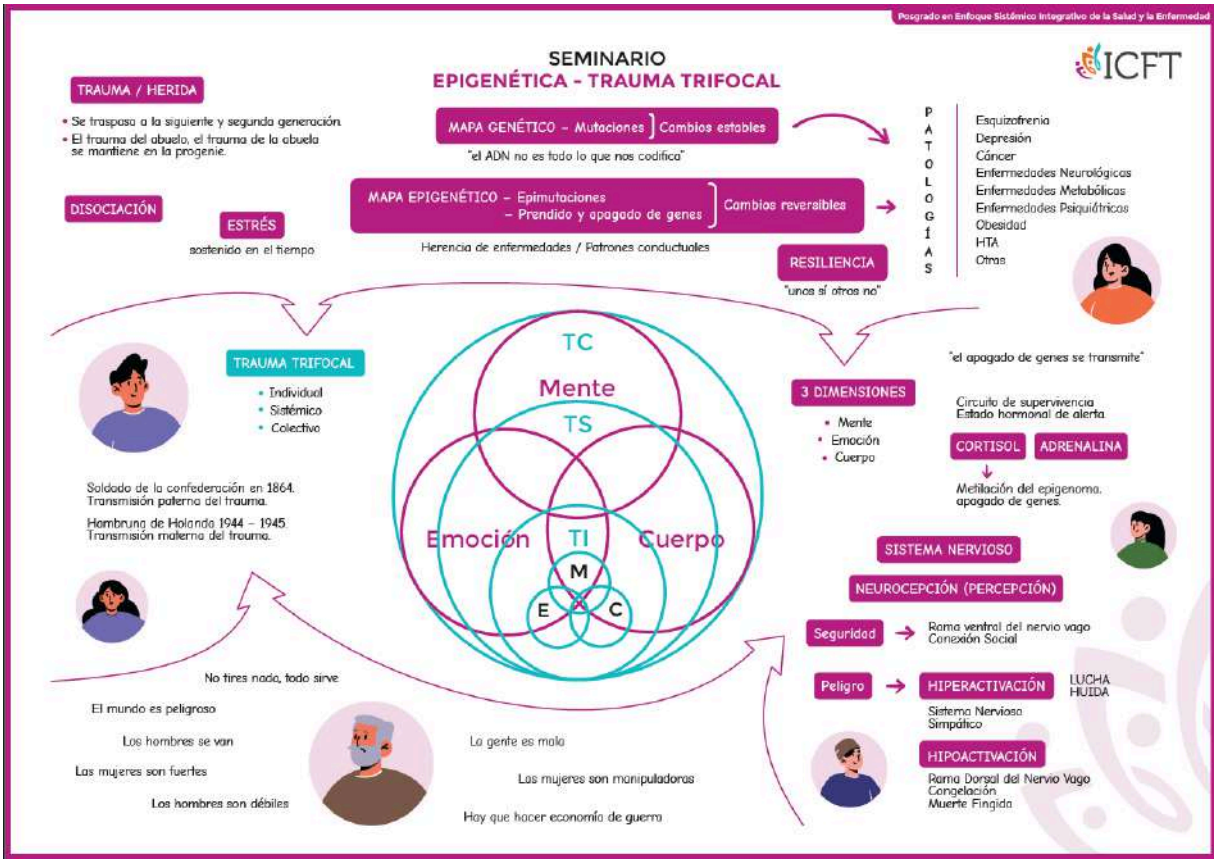
Proceso mediante el cual aspectos de la vida psíquica —incluyendo identificaciones, mandatos, traumas y defensas— se re-transmiten entre generaciones. Esta transmisión no implica una reproducción literal de contenidos, sino la persistencia de dinámicas que pueden reaparecer bajo formas transformadas en la vida del sujeto.

Trauma trifocal:

Modelo clínico integrativo propuesto por la Dra. VMG que plantea la necesidad de abordar el trauma considerando tres dimensiones interrelacionadas: el foco individual (biografía y desarrollo), el foco sistémico (dinámicas familiares y transgeneracionales) y el foco colectivo (eventos históricos y sociales). Este enfoque articula, además, los niveles de experiencia corporal, emocional y cognitiva en la comprensión del sufrimiento humano.

ANEXOS

I. Infografía: Lectura Clínica del Mapa Epigenético y el Trauma Trifocal.



La infografía titulada *Seminario Epigenética - Trauma Trifocal* de la Dra. VMG constituye una cartografía visual y conceptual que sintetiza la intersección entre la transmisión transgeneracional, la neurobiología del estrés y los desarrollos metapsicológicos, ofreciendo un modelo integrador para la comprensión del trauma en la clínica contemporánea.

En un primer nivel de lectura, el esquema establece una distinción fundamental entre el mapa genético y el mapa epigenético. Mientras que el primero refiere a la secuencia relativamente estable del ADN, el segundo alude a mecanismos dinámicos de regulación génica —como la metilación del ADN, las modificaciones de histonas y la acción de ARN no codificante (ARNnc), que modulan la expresión de los genes sin alterar su secuencia (Turecki & Meaney, 2016).

Desde esta perspectiva, la afirmación de que "el ADN no es todo lo que nos codifica" remite a la creciente evidencia que muestra que experiencias ambientales —particularmente el estrés crónico o temprano— pueden influir en estos mecanismos regulatorios. Diversos estudios han señalado que la activación sostenida del Sistema Hipotalámico Hipófiso Adrenal (HHA)), mediada por hormonas como el cortisol, puede asociarse con cambios epigenéticos en genes vinculados a la respuesta al estrés (Meaney & Szyf, 2005).

No obstante, es importante subrayar que, en humanos, la transmisión de estos cambios a través de generaciones constituye un campo de investigación en desarrollo. La evidencia actual es consistente con procesos de transmisión intergeneracional del estrés, aunque no permite afirmar de manera concluyente una herencia epigenética directa y universal del trauma (Horsthemke, 2018; Zhou & Ryan, 2023).

El núcleo de la representación visual expone el modelo del Trauma Trifocal mediante círculos concéntricos que articulan las dimensiones del Trauma Individual (TI), Sistémico (TS) y Colectivo (TC) con los registros de Mente (M), Emoción (E) y Cuerpo (C). Esta integración permite comprender cómo experiencias biográficas, dinámicas familiares y eventos históricos pueden converger en la configuración del sufrimiento psíquico y somático.

Ejemplos paradigmáticos ya mencionados como la Hambruna de Holanda (Heijmans et al., 2008) o los efectos intergeneracionales observados en descendientes de sobrevivientes del Holocausto (Yehuda et al., 2016), ilustran cómo condiciones extremas pueden asociarse con variaciones biológicas y psicológicas en generaciones posteriores. Estas influencias se expresan clínicamente no sólo en términos biológicos, también como creencias, mandatos y lealtades inconscientes que organizan la experiencia subjetiva.

Finalmente, el modelo se articula con la biología del sistema nervioso a través del concepto de neurocepción, desarrollado por Porges (2004, 2011), que describe el proceso mediante el cual el organismo evalúa señales de seguridad o peligro en el entorno.de forma automática.

En condiciones de seguridad, se activa la vía vagal ventral, facilitando la conexión social y la regulación emocional. En contextos de amenaza, el sistema nervioso puede activar respuestas de hiperactivación simpática (lucha o huida) o de hipoactivación parasimpática dorsal (congelamiento o colapso), configurando estados fisiológicos que impactan en la experiencia subjetiva y en la posibilidad de simbolización.

En suma, esta infografía ofrece al clínico una herramienta de lectura integradora que permite estructurar los niveles biológico, psíquico y vincular del trauma. Desde esta perspectiva, la resiliencia no se concibe como un rasgo individual aislado, sino como el resultado de un entramado dinámico donde la regulación del estrés, la simbolización y la calidad de los vínculos desempeñan un papel central en los procesos de transformación subjetiva.

II. Artículo: Familia, Trauma y Salud, por Verónica Molina Gerstner



El dolor que no tiene espacio en la conciencia, encuentra escenario en el cuerpo.
Joice Mc Dougall

Los seres humanos somos seres vinculares. Hemos descubierto a lo largo de nuestra evolución, que estar juntos, en manada, en un grupo de pertenencia propio de la especie, aumenta drásticamente las posibilidades de sobrevivir, desarrollarse y lograr bienestar.

En el mundo contemporáneo, donde las reglas de la sociedad llevan a la expectativa de felicidad permanente, un mundo de evitación de conflictos y dificultades, se espera que lo inmediato y lo fugaz den alivio a la angustia de esperar al otro y, a la vez, de comprometernos a estar para el otro. En este mundo, vale la pena darnos un espacio para reflexionar sobre una posición que es necesaria asumir como terapeutas a la hora de acompañar familias, parejas o individuos desde un enfoque sistémico. Esta reflexión que desarrollaré en las próximas páginas, contiene autores diversos y mi propio modo actual de pensar la psicoterapia, es

una invitación a articular tres ejes de la naturaleza humana, que, en mi visión, se interrelacionan e influencian:

Los lazos tempranos con los padres y cuidadores formulan definiciones y modelos intrapsíquicos constituyentes de la subjetividad en el psiquismo del infante, que lo convierten en un cuerpo sentido y simbolizado.

Estos lazos vinculares moldean, a su vez, dinámicas relacionales que perdurarán activas durante la vida adulta. Las diversas teorías del apego demuestran desde hace más de 60 años, la importancia no sólo del cuidado adecuado por parte de los referentes, sino también de la salud psicoafectiva de los mismos, siendo el psiquismo y el sistema nervioso (en términos biológicos), el ámbito donde más podemos observar el impacto y la impronta de lo acontecido en la infancia y el modelo de pasaje transgeneracional del apego.

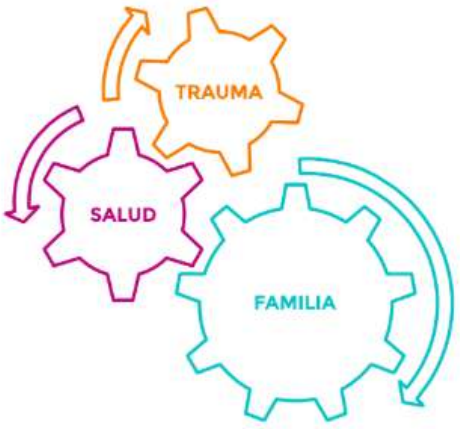
Lo individual, lo familiar y lo social son mundos interconectados e interdependientes que se influencian y co-construyen mutuamente, creando así un todo global que se manifiesta en el sujeto, en su psiquismo y en su propio cuerpo como expresión de la cultura misma, de los valores e historias familiares y, por supuesto, de lo vivido por el sujeto en su propia biografía. Somos seres vinculares y vinculantes. Somos en la relación con otro.

Nuestro inconsciente surge de la fusión primaria con el inconsciente materno durante nuestros primeros meses de vida y, con el inconsciente familiar global, a lo largo de toda nuestra vida. Es indudable la importancia de revisar nuestra historia familiar dentro del proceso terapéutico individual para poder aproximarnos a heridas básicas, fundantes y generatrices de defensas estructurales de la neurosis, mecanismos ciegos de repetición, identificaciones inconscientes, lealtades invisibles transgeneracionales verticales u horizontales, traumas y duelos no elaborados.

De ahí que, considero, tiene sentido plantear esta dinámica de tres ruedas y revisar algunos conceptos donde FAMILIA, SALUD y TRAUMA son una unidad estructural interrelacionada y que cuando nos aproximamos a uno de los temas, estamos, inevitablemente, tocando los otros dos.

Hablar hoy de familia es en sí un desafío. ¿Cómo definir hoy qué es una familia? En épocas de revisión, remodelación, revoluciones culturales y científicas donde es posible, por primera vez en la historia de la humanidad, que una mujer pueda por sí misma ser madre con ayuda de la ciencia y sin la participación física de un hombre, en el contexto de una relación sexual.

Definir familia creo, es hoy, una oportunidad de ampliar la mirada y extendernos más allá de definiciones biologicistas de lazos de consanguinidad y poder incluir también en este universo



a todos los que aun, sin unión de sangre, construyen lazo y vínculo, con amor, cuidado y aportando a la creación y sostenimiento saludable de la vida. Así, familia puede configurarse, por ejemplo,

a través de donantes de gametos, personas que subrogan útero, padres de crianza que darán el apellido y el cuidado.

Quizá todos sean *familia* para un hijo, si entre los adultos hay acuerdo y disponibilidad para reconocer esta comunidad de colaboración que permitió la vida, el amor y el cuidado. Si es difícil definir familia hoy, asimismo lo es definir salud. Venimos de concepciones antiguas, biologicistas, cartesianas que enuncian como salud -según definiciones clásicas de OMS- a un estado de ausencia de enfermedad o, posteriormente, a un estado de equilibrio biosocial de los individuos.

Estas definiciones se basan en que la tensión salud-enfermedad se dirime en el organismo, excluyendo así ámbitos de la vida del sujeto que están vinculados con su subjetividad, su propia búsqueda de sentido, sus sentimientos y emociones, su inserción social, su lugar en la comunidad, su capacidad de autosostenerse económicamente y de desarrollar su proyecto de vida y vocación.

Si incluyéramos todos estos niveles de la experiencia humana que, según Pichón Riviere son inherentes al ámbito de la salud, ¡cuánto más vasta sería entonces esta definición! Quizás así, la salud no estaría reducida a la mera ausencia de enfermedad orgánica, sino relacionada a la posibilidad de los sujetos de estar en relación consigo mismos, con su propio cuerpo y emociones, de establecer lazo y relación con otras personas, de tener sus propios proyectos y poder sostenerlos, de autosostenerse económicamente y de atravesar situaciones desafiantes, generando mayor resiliencia y cooperación con su comunidad.

Creo, que esta definición artesanal de salud incluye diversas áreas de desarrollo de los seres humanos y habilita la revisión del concepto en un sentido realmente integrativo , comprendiendo al sujeto como un ser biológico, vincular y social.

En este punto, es importante seguir profundizando la idea de que los seres humanos somos fuertemente influenciados biológicamente, en nuestra vincularidad.

A diferencia de lo que se pensaba en la primera parte del siglo XX, nuevas teorías somato-clínicas, como la teoría polivagal de Stephen Porges, demuestran con toda claridad la importancia de los lazos de confianza y afecto, no sólo en términos del desarrollo neuropsicológico del infante (como ya lo enunciaban oportunamente Bowlby, Ainsworth, Winnicott y otros), sino también en el despliegue adulto de las potencialidades de vivir una vida más saludable en el sentido planteado anteriormente. Porges descubre y describe un desarrollo neurobiológico evolutivo propio de los mamíferos que, por supuesto, está presente en los seres humanos; donde el sistema nervioso autónomo en su rama parasimpática provee no sólo la vía del equilibrio y corregulación simpático-parasimpático, además de la defensa parasimpática (vía arcaica más antigua responsable del congelamiento /muerte fingida /disociación). Asimismo, este nivel del SNA parasimpático en su rama ventral (vía última de evolución con fibras vago ventrales, mielinizadas) opera en contexto de conexión social y confianza: como un switch-off al pánico, encendiendo la percepción de seguridad y reparo dada por la presencia de otro ser humano, otro que puede dar sensación de alivio, cuidado, co-preservación.

Es tan importante para los seres humanos la presencia del otro en momentos de peligro, que su sola existencia, nos alivia y desencadena respuestas de bienestar físico,

organización psíquica, conexión social, empatía y relajación.

Esta vía vagoventral se desarrolla en la primera infancia, luego del nacimiento donde el bebé durante sus primeros dos años de vida es, como lo menciona Winnicott en su desarrollo, sostenido, tratado y cuidado de un modo suficientemente bueno.

Porges aporta de alguna manera, la confirmación neurobiológica a las teorías del apego de la escuela inglesa. Este *holding* y *handling* y la presentación objetal son puro estímulo de la vía ventral del sistema parasimpático que va mielinizándose como retroalimentación positiva al estímulo del adecuado cuidado materno: esto es muy revelador en las observaciones científicas del neurodesarrollo del apego. El sistema nervioso del infante responde y se despliega biológicamente si hay una matriz de estímulo afectivo y de contacto corporal y emocional adecuados, de modo que, si el estímulo fuera insuficiente, desconectado o peor aún ausente o violento, el desarrollo podría interrumpirse generando vías vago ventrales insuficientemente mielinizadas y, por ende, menos sensitivas y empáticas, dando prioridad al estímulo de vías más arcaicas y menos intervinculares, como la vía dorsal que resulta en congelamiento, disociación y desconexión afectiva y somática.

Somos seres biológicamente vinculares y vinculantes. Tan esencial es para nosotros el otro, que ser y existir es en función de ese otro que en un inicio nos da mirada, existencia y, luego, es esa presencia que nos da reparo y sentido de cobijo tribal.

Ésta es una dimensión de la salud íntimamente relacionada con la familia, y desde ya, con el trauma, ya que es en contextos de trauma que se producen los desencuentros y perturbaciones de los vínculos. Ya sean traumas del apego, de la vida adulta o traumas transmitidos sistémica o socialmente, van a ir configurando modos vinculares basados en la distancia emocional y física, la desconfianza, la desconexión, las dificultades en la individuación (fusión/separación) y los trastornos en la comunicación.

Trauma -en su definición clásica- es enunciado por Freud en la teoría sexual desde una concepción económica "una experiencia vivida que aporta, en poco tiempo, un aumento tan grande de excitación a la vida psíquica, que fracasa su liquidación o su elaboración por los medios normales y habituales, lo que inevitablemente da lugar a trastornos duraderos en el funcionamiento energético".

El aflujo de excitaciones es excesivo en relación a la tolerancia del aparato psíquico, tanto si se trata de un acontecimiento único muy violento, como de una acumulación de excitaciones, cada una de las cuales, tomada aisladamente, sería tolerable.

Estas definiciones se asientan en la base del psicoanálisis freudiano de 1890, que describe teóricamente la etiología de las neurosis asociándose a experiencias traumáticas pasadas. Freud amplía su visión sobre el trauma en *Más allá del principio del placer*, donde enuncia la hipótesis de que un flujo excesivo de excitación anula inmediatamente el principio de placer obligando al aparato psíquico a realizar una tarea más urgente, consistente en ligar excitaciones de forma que se posibilite la descarga ulterior.

Así, en los sueños, por ejemplo, se revive la experiencia traumática para intentar controlarla. Freud lo denomina "*compulsión a la repetición*", donde observa que, para que el principio de placer pueda funcionar, deben darse determinadas condiciones que son

abolidas por acción del traumatismo. Éste no sólo sería una simple perturbación de la economía libidinal, sino que realmente viene a amenazar más radicalmente la integridad del sujeto.

Hace más de 100 años, Freud enunciaba el carácter emergente del trauma psíquico, que va más allá del trauma sexual y la génesis de la neurosis: en pleno transcurso del trauma social durante la Primera Guerra Mundial, observando los traumas de guerra de los sobrevivientes, incluye otro modelo de funcionamiento del aparato psíquico que emerge ante el peligro de vida y que no se resuelve por haber logrado sobrevivir, sino que demuestra la necesidad humana básica de pertenencia y, según Iván Boszormeny-Nagy, la búsqueda de justicia transgeneracional.

Eros y *Thanatos*, el libro contable inconsciente transgeneracional; los hilos de lealtad que actúan en los grupos donde existen lazos vinculantes y cómo estos lazos unen a los sujetos más allá de la vida, de la muerte, de la sobrevivencia e, incluso, más allá del sufrimiento y del placer.

Pensar el trauma desde el psicoanálisis entonces , abre al menos dos grandes temas que debemos revisar: el trauma individual y su expresión somática y, por otro lado, la dimensión sistémica del trauma, es decir, la huella familiar y social de los eventos altamente agobiantes.

La dimensión individual del trauma

Autores más contemporáneos, que vienen estudiando e investigando en la clínica del trauma, señalan en sus observaciones cómo en casos de trauma severo no es suficiente la palabra como camino hacia la cura y la resignificación traumática. (incluso puede ser retraumatizante en algunos casos), sino que es necesario traer a la escena consciente el plano subjetivo del cuerpo y sus expresiones en tiempo presente dando lugar a que se completen, en ese escenario de repetición del que hablaba Freud, aquellas respuestas somáticas que no fueron seleccionadas por los mecanismos neurobiológicos de supervivencia.

Así, por ejemplo, ante una escena traumática de la vida adulta como puede ser un robo, el sistema nervioso, que es jerárquico en su modo de funcionamiento, le da prioridad a los niveles más evolucionados de desarrollo con lo que ante una escena de violencia es posible que el cerebro cognitivo defina que lo mejor y más seguro para la autopreservación sería entregar los objetos reclamados por el atacante, no desafiarlo, hacer todo lo que él solicita y esperar así que el mismo se retire satisfecho de llevarse todo lo que la víctima tiene en su poder.

Sin embargo, en ese mismo momento donde el cerebro cognitivo decide y opera actuando de este modo "coherente" con nuestro desarrollo, otros niveles del sistema nervioso pueden estar siendo inhibidos eficazmente en su accionar, pero inhibidos no es anulados: por ejemplo, en este momento del ataque, la víctima puede en un nivel querer correr y escapar del atacante, y a la vez quizás también desee luchar contra él y descargar toda su ira por ser injustamente atacada y agredida e incluso también desee pedir ayuda y gritar esperando que el entorno reconozca el peligro y el ataque y pueda acudir en su ayuda.

Tal vez incluso se sucedan más pensamientos en milésimas de segundo, como, por ejemplo, otras escenas traumáticas que estén asociadas ya sean personales o familiares, o pensamientos de cuidado de otros como "menos mal que esto me pasa a mí y no a mi hija" o

sentimientos complejos de culpa "por qué justo hoy salí con tanto dinero encima" o de desconfianza "alguien le debe haber dicho que hoy yo tenía el dinero conmigo"... En fin, en esos segundos pueden sucederse miles de pensamientos y respuestas físicas diversas, incluso contradictorias.

Sin embargo, una prevalece y es ejecutada, la más racional y segura en términos de sobrevivencia y experiencia ancestralmente recogida por generaciones.

Esta respuesta actúa, sin embargo, todas las demás se inhiben pero no se anulan, y éste es el descubrimiento de autores actuales especializados en trauma, aquello que no se actúa permanece en el registro somático de este recuerdo como un pendiente y, muchas veces, es necesario sumar estrategias que incluyan el registro subjetivo y "en vivo, en sesión" del cuerpo y de inteligencia emocional, a los recursos analíticos que permitan en el momento donde emerge el recuerdo y la asociación de lo traumático, integrar el cuerpo como aliado que trae su propia sabiduría a la sesión y permite, si es escuchado adecuadamente por el analista, liberar respuestas inhibidas que pueden haber quedado guardadas por décadas, generando alivio, mejoría en diversos síntomas, mayor tendencia a elaborar y resignificar lo traumático.

Por otro lado, e invitando al otro tema planteado en relación al trauma y lo vincular, también es posible observar en la clínica mecanismos inconscientes de repetición familiares, transgeneracionales y sociales.

Diversos autores lo desarrollan en mapas de interpretación y tratamiento del trauma: desde el mismo Freud en diversas partes de su obra, Lacan, A. Eiguer, Kaës, Abraham y Torok, A. Green, Iván Boszormeny-Nagy, Franz Ruppert, entre otros.

La transmisión de la vida psíquica

"Y, por otra parte, la constitución misma, ¿no sería la resultante de todos los acontecimientos fortuitos que influyeron sobre la infinita serie de nuestros antepasados?"

S. Freud, "La dinámica de la transferencia".

El hombre existe como individuo y como miembro de una cadena generacional que cumple sin su voluntad consciente los objetivos del grupo y la especie.

Existe un impulso por transmitir, un imperativo psíquico, una necesidad inconsciente vinculada a la pulsión de conservación y de continuidad de la vida psíquica.

Esta pulsión de conservación, integrada en Eros, constituye el inconsciente hereditario y su objetivo es la transmisión de la genética y la cultura a los sucesores. Es inherente al ser humano la pertenencia al grupo. Desde el nacimiento, ya somos miembros de distintos espacios psíquicos intersubjetivos desde los cuales nos es transmitida por vía psíquica la formación de ideales, referencias identificatorias, representaciones, mecanismos de defensa, creencias, mitos, ritos e ideologías.

En la concepción del sujeto psíquico como inseparable del grupo, es donde se entrecruzan la transmisión intrapsíquica y la intersubjetiva. La familia es el grupo primario y el espacio originario de la intersubjetividad, donde el niño hereda el material psíquico indispensable a través de sus filiaciones materna y paterna. Son los vínculos intersubjetivos de apuntalamiento e investiduras narcisistas, los enunciados de prohibiciones fundamentales que ponen en marcha la representación de cada uno

y se constituyen los objetos, los vínculos de identificación y las estructuras básicas del yo y superyó (Kaës, 1993).

Cada familia posee sus propios mitos, generalmente relacionados a la idea de familia ideal que despliegan sobre alguna de las ramas del árbol genealógico, muchas veces excluyendo otras partes del sistema e incluso aspectos traumáticos que son parte de la historia familiar.

Estos mitos tienen una función estructurante en las familias, generan identificación, pertenencia e identidad en sus miembros y son parte del pasaje transgeneracional. La pareja es la portadora básica de la transmisión que en circunstancias favorables transmite todo aquello que garantiza y asegura las continuidades, el mantenimiento de los vínculos intersubjetivos, de las formas y de los procesos de conservación de la vida.

Es decir, pueden formar una nueva familia en que las transmisiones se den con desarrollos propios o, por el contrario, en circunstancias desfavorables pueden ser causas de perturbaciones en el grupo familiar o en alguno de sus miembros.

El niño nace ya con una historia genética, vincular y emocional, hereda la "carga" de recomponer a la familia a partir de la alianza de los dos linajes de los que ha nacido; por lo tanto, hay una historia que lo preexiste, de la cual puede ser heredero transmisor con nuevos desarrollos, o en ocasiones, tan sólo prisionero de ella (Rozenbaun, 2005).

En *Tótem y Tabú* (1912-1913), Freud aborda la transmisión por imitación y distingue entre imitación e identificación. Dice que hay dos vías de transmisión, por un lado, la tradición y la cultura cuyo soporte es el aparato social que asegura la continuidad y, por otro, la que está constituida por esta parte orgánica de la vida psíquica de las generaciones siguientes. Si los procesos psíquicos de una generación no se transmitieran a las siguientes, quedaría detenido el desarrollo de la humanidad y sin la hipótesis de la continuidad de la vida psíquica, no existiría la psicología colectiva.

En *Moisés y la religión monoteísta* (1939), afirma que a la herencia arcaica del hombre la forman fragmentos de vida psíquica transmitida de generación en generación que constituyen el bagaje inconsciente: "en la vida psíquica del individuo tienen eficacia no sólo los contenidos vivenciados por él mismo sino otros que le fueron aportados con el nacimiento, fragmentos de origen filogenético, una herencia arcaica, lo que sería el factor constitucional del individuo".

La consideración de las huellas mnémicas referidas a lo vivido por generaciones anteriores, le añade amplitud e importancia a la herencia arcaica y se amplía la dimensión ontogenética a la filogenética.

Podemos considerar a la transmisión generacional como el modo natural en que los saberes, los bagajes emocionales y los legados se traspasan a los herederos. Pero la herencia no puede ser recibida pasivamente, sino que requiere el trabajo de hacerla propia y así, tomar lo que el sistema da.

De este modo, vemos la importancia del planteo sistémico y transgeneracional a la hora de ampliar la mirada y el foco de análisis de la clínica individual. Pensando en aquello que genera síntomas en las familias y que se hereda transgeneracionalmente, observamos desde síntomas físicos que Freud mismo describe, por ejemplo, en el caso Dora, (donde ella presentaba la misma tos que su papá y la interpretación de Freud en aquel momento era la de un mecanismo

de identificación donde a través del síntoma, Dora lograba acercarse a su padre) hasta cargas sistémicas generacionales y transgeneracionales más complejas ligadas a los secretos, la mentira, los duelos traumáticos, la culpa, los traumas individuales y familiares, donde lo innombrable opera en el inconsciente familiar generando escisiones profundas entre el impulso y el deseo de saber y la necesidad de pertenecer y acatar las reglas del grupo.

En este punto lo no dicho, lo secreto, lo que no tiene representación, no puede ser tampoco metabolizado por el psiquismo. Bion (1967) definió muy bien la génesis de lo no representado en el desarrollo precoz. Cuando la madre tiene importantes fallas en la capacidad de rêverie: ésta no puede contener las proyecciones de elementos beta del bebé, ayudarle en su transformación a elementos alfa y al proceso de mentalización.

En estos casos podríamos decir que predomina una transmisión de elementos no representables, de objetos enquistados o inertes que son transferibles como identificaciones proyectivas o adhesivas.

Según Werba (2002), cuando los padres no pueden denominar determinadas experiencias emocionales y los hijos no pueden darle representación verbal, esto conducirá a una imposibilidad de simbolización.

Así, lo que en una primera generación es indecible, en la segunda se transforma en innombrable y en la tercera en impensable.

En este sentido, cuando en la clínica el paciente nos expresa imágenes, sensaciones o emociones vividas como extrañas, síntomas corporales que para él mismo revisten un carácter incomprensible, angustias sin nombre o síntomas que no se explican desde su propia vida psíquica, es posible que estemos ante elementos impensables transmitidos inconscientemente de generaciones anteriores (Nachin, 1995). Alberto Eiguer describe también en un análisis interesante de la transmisión transgeneracional del fantasma, el caso del espectro, definido y analizado por Abraham y Torok, donde un antepasado cercano o lejano, cometió un acto reprobable que todos ignoran o mantienen en secreto. Así, un descendiente se ve sujeto a comportamientos y reacciones que el entorno no comprende, pero recuerda precisamente el comportamiento del antepasado negado.

El sujeto no oyó nada de esta historia que funciona en su fantasma como el personaje central de un duelo no resuelto.

La investidura libidinal correspondiente al ancestro, que absorbe el funcionamiento mental del sujeto e impide la función alfa, son en realidad pensamientos que no pueden ser pensados (beta) pero que regresan a través del delirio o algún otro síntoma. (Bion, en el relato de Eiguer).

Lo innombrable puede adquirir la forma de fobias, compulsiones obsesivas y problemas en el aprendizaje, que no están sólo ligadas al conflicto entre deseo y prohibición sino también al conflicto entre el deseo de saber y las dificultades que los padres imponen a ese deseo de conocimiento (Tisseron, 1995).

En medios familiares en que las situaciones de conflicto son tramitadas, sea con comunicaciones confusas o enigmáticas, sea a través del silencio y el secreto, la modalidad de transmisión a los hijos se puede manifestar como una importante inhibición del impulso epistemofílico y por tanto de la

curiosidad, el deseo de saber y de investigar.

Otra forma concreta de transmisión se presenta a través de un síntoma que puede ser repetición idéntica del síntoma de uno de los padres o una formación nueva, pero con un vínculo directo con alguna patología parental. Esto es lo que Kaës (1983, 1989) denomina "anudamiento intersubjetivo del síntoma".

Esta transmisión del síntoma puede ser vivida con mucha violencia, como una maldición, como estar atado al destino del otro desde antes de los orígenes, pero precisamente esta manera de experimentarlo por parte del paciente, puede promover la necesidad de diferenciación respecto del objeto parental.

Sin embargo, en otros pacientes ese síntoma se repite en silencio, es visible pero no audible y suele estar muy arraigado a su identidad.

En estos casos, las posibilidades de hacer consciente lo que el síntoma representa puede ser muy costoso, se ha de tratar cuidadosamente en el tratamiento porque "tocarlo" puede ser vivido con angustias catastróficas.

En esta cuestión del anudamiento del síntoma, sería interesante investigar sobre filiaciones de síntomas dentro de las familias. Otro modo en que la transmisión se manifiesta en la clínica es en forma de "la delegación" al hijo, que consiste en una demanda inconsciente vinculada al narcisismo parental y a las aspiraciones no realizadas por los padres.

En esta modalidad de transmisión, un aspecto de los ideales del yo y el superyó de los padres asumidos por el hijo, impulsan a éste a cumplir un "encargo" que no han podido transformar en herencia propia.

Este tipo de demanda parental, normalmente muy cargada emocionalmente, puede también generar el efecto contrario, es decir, la necesidad de anular la filiación, lo que implica la renuncia a los orígenes y la decisión de no tener hijos, como único modo de interrumpir la transmisión.

De la familia a la cultura

No quisiera dejar de nombrar la importancia de la cultura como generadora de pertenencia, ritos, costumbres e identidad.

Es en la cultura donde se inscriben las bases de los modelos vinculares que se desplegarán en las familias generando a su vez estructuras, mecanismos de defensa y traumas, pero también recursos, formas de lidiar con el dolor, de atravesar los desafíos de la vida, de acompañarse y estar con otro.

El trauma, en su dimensión social, surge de experiencias altamente agobiantes vividas por una comunidad toda y de su capacidad de salir airosa de la adversidad.

Si el grupo logra mayor resiliencia, es decir, sale fortalecido y más seguro de sí mismo, con miembros que mantienen lazos de confianza entre sí y pueden, pasado el evento adverso, celebrar juntos aquello que lograron, el evento puede no dejar huellas traumáticas significativas, sino ser incluso fortalecedor.

Sin embargo, si la comunidad no cuenta con recursos de apoyo mutuo y entra en el devenir de la autopreservación en detrimento de la empatía y el cuidado del otro, es posible que el evento deje huellas en la comunidad del orden del trauma social.

Estas huellas con el paso del tiempo y las generaciones, se van consolidando en fantasmas colectivos, maneras de pensar y leer la realidad, de sentir y recibir al

otro, de conectarse con los demás e incluso de crear lenguaje.

De esta manera, es importante como terapeutas tener el horizonte del trauma social presente en el análisis de nuestros pacientes, dedicarle al genograma en su función analítica, un aspecto transgeneracional y social observando los países y culturas de origen de las familias que componen el sistema, para así poder comprender el entramado en el que su sistema familiar está inserto y por el que se ve íntima e inconscientemente influenciado.

Para cerrar esta reflexión, comparto un poema de Mary Oliver:

Cuando estoy entre los árboles,
especialmente los sauces y las acacias,
también las hayas, los robles y los pinos,
desprenden una felicidad sutil. Casi diría
que me salvan, cada día.

Estoy tan distante de mi propia
esperanza, en la cual tengo bondad y
discernimiento, y nunca me apresuro por
el mundo sino que ando despacio y
saludo inclinando la cabeza.

En torno a mis árboles se mueven en sus
hojas, y
llaman "quédate un rato", la luz fluye de
sus ramas. Y
llaman otra vez, "es simple", dicen
y tu también has venido al mundo para
hacer esto,
fluir, estar llena de luz y brillar...

Entiendo que, así como los árboles en el poema, los procesos terapéuticos tanto del individuo que es analizado con una visión sistémica, como de las parejas y familias; apuntalan esta conciencia del dolor, del saber de sí, de hacer consciente aquella historia inconsciente que nos habita, así como a las personas que la componen.

Lo pasado que sigue siendo presente en el devenir repetitivo de sus miembros, el alivio de lo nuevo que surge y luego se percibe simple, pero fue el fruto de una fuerte e íntima apuesta personal: conocerse más y mejor para ir conquistando la sana pertenencia y la diferenciación que, por adecuada, vincula, conecta y permite ser en relación y trascender viviendo. Como los árboles, la belleza de la simple existencia en el bosque diverso y cooperativo de nuestra maravillosa y sorprendente humanidad.



Dra. Verónica Molina Gerstner

Médica, psicoterapeuta integrativa con enfoque humanista. Especializada en el abordaje sistémico según Bert Hellinger y terapia del trauma. Docente, supervisora y conferencista. Fundadora y directora del ICFT (Instituto de Constelaciones Familiares y Abordaje del Trauma). Miembro de la Fundación de Constelaciones Familiares, Asociación Argentina de Salud Mental y Federación Mundial de Salud Mental.

Bibliografía:

• Diccionario de Psicoanálisis. Laplanche-Fontalis, Paidós 1996.

• Lealtades Invisibles. Iván Boszormenyi-Nagy, Geraldine Spark. Amorrortu, 2008.

• Terapia Familiar Intensiva. Iván Boszormenyi-Nagy, James Framo. Ed Trillas. 1976.

• El parentesco fantasmático. Alberto Eiguer. Amorrortu. 1987.

• Lo inconsciente. Donald Winnicott, Andree Green, O Mannoni, J B Pontalis y otros. Ed Trieb. 1978.

• Transmisión de la vida psíquica entre generaciones. R Kaës, H Faimberg, M Enríquez, J Baranes. Amorrortu. 1996.

• Los juegos del mal amor. Marcelo Ceberio. Ediciones B. 2017.

• Diagnóstico Sistémico. H Serebrinsky, Sonia Rodríguez. Psicolibros Ed. 2014.

• Sanar el trauma. Peter Levine. Ed neo Person 2013.

• Sanar el trauma colectivo. Thomas Hübl. Gaia Ed. 2021.

• Teoría Polivagal. Fundamentos neurofisiológicos de las emociones, el apego, la comunicación y la autorregulación. Stephen Porges. Ed Pleyades. 2011.

Pluma Lalangue

PSIQUE, CUERPO Y TRAMA VINCULAR

COLECCIÓN Grupos de Estudio Lalangue

¿Qué sucede cuando el dolor no encuentra palabras? La clínica contemporánea nos enfrenta a *dolores mudos* y angustias sin nombre que, al no hallar lugar en el teatro de la mente, terminan escenificándose en el cuerpo.

Este ebook, fruto del grupo de estudio dirigido por la Dra. Verónica Molina Gerstner, propone un recorrido profundo por el componente evolutivo del síntoma. A través de un abordaje trifocal, se exploran las intersecciones entre el psicoanálisis estructural, las neurociencias afectivas y la trama vincular, ofreciendo herramientas para intervenir allí donde la palabra parece insuficiente.

En estas páginas, el lector explorará la lógica del síntoma somático y cómo el cuerpo logra *hablar* aquello que el sujeto aún no puede simbolizar, estableciendo un diálogo necesario entre las neurociencias y el psicoanálisis para comprender el trauma y la regulación afectiva. Asimismo, se profundiza en la trama vincular y transgeneracional, analizando el impacto de las lealtades invisibles y los secretos familiares en la economía corporal, para finalmente brindar claves sobre el cuerpo en la transferencia y una escucha clínica que integre la presencia física y lo no dicho.